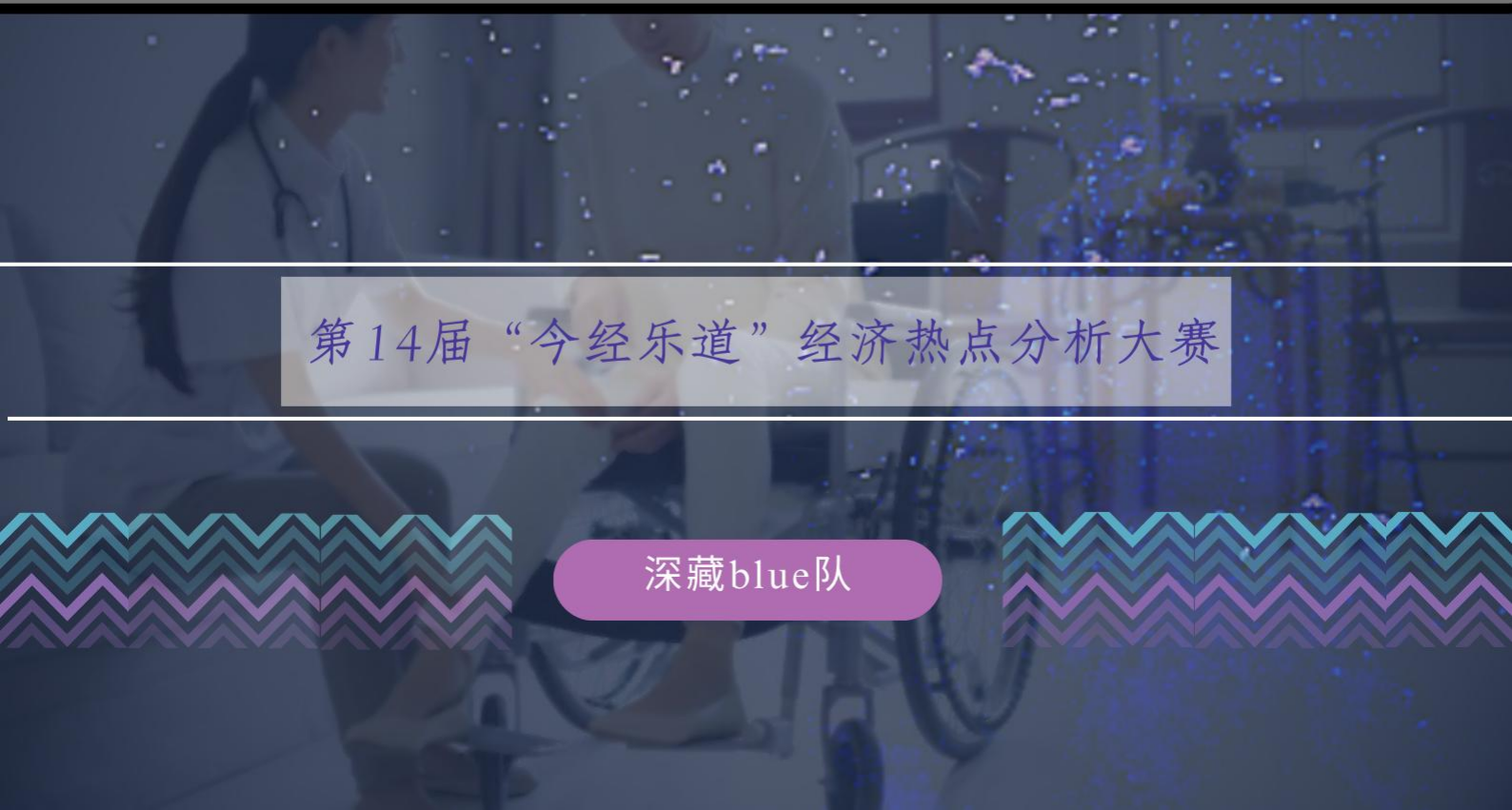
以心长护
以爱保险

“银发经济”呼唤下我国长护险体系发展之道



第14届“今经乐道”经济热点分析大赛

深藏blue队

研究摘要

为协同推进“积极老龄化”与“健康中国”战略，持续满足老年人健康需求，解决失能人员保障难题，进一步提升老年人健康水平，我国自 2012 年开始长期护理保险试点。该保险用于应对老龄化产生的失能风险。老龄化虽代表社会进步和人民整体健康水平提高，但也会妨碍社会长期良性发展。如此庞大且脆弱群体的健康问题，必然给我国社会生活和经济发展带来巨大压力与挑战，并且家庭养老功能难以满足需求，老年人失能风险会逐渐由家庭风险转化为社会风险。在此背景下探讨老年长护险对我国经济的影响具有重要意义。

从必要性和可行性来看，人口老龄化带来诸多困境，如老年人口比例上升增加家庭和社会负担，同时“银发经济”相关产业蓬勃发展带来机遇，包括政策支持、市场潜力巨大和现实意义重大等，且我国养老问题复杂，养老金融体系问题重重，发展长护险是破局关键。

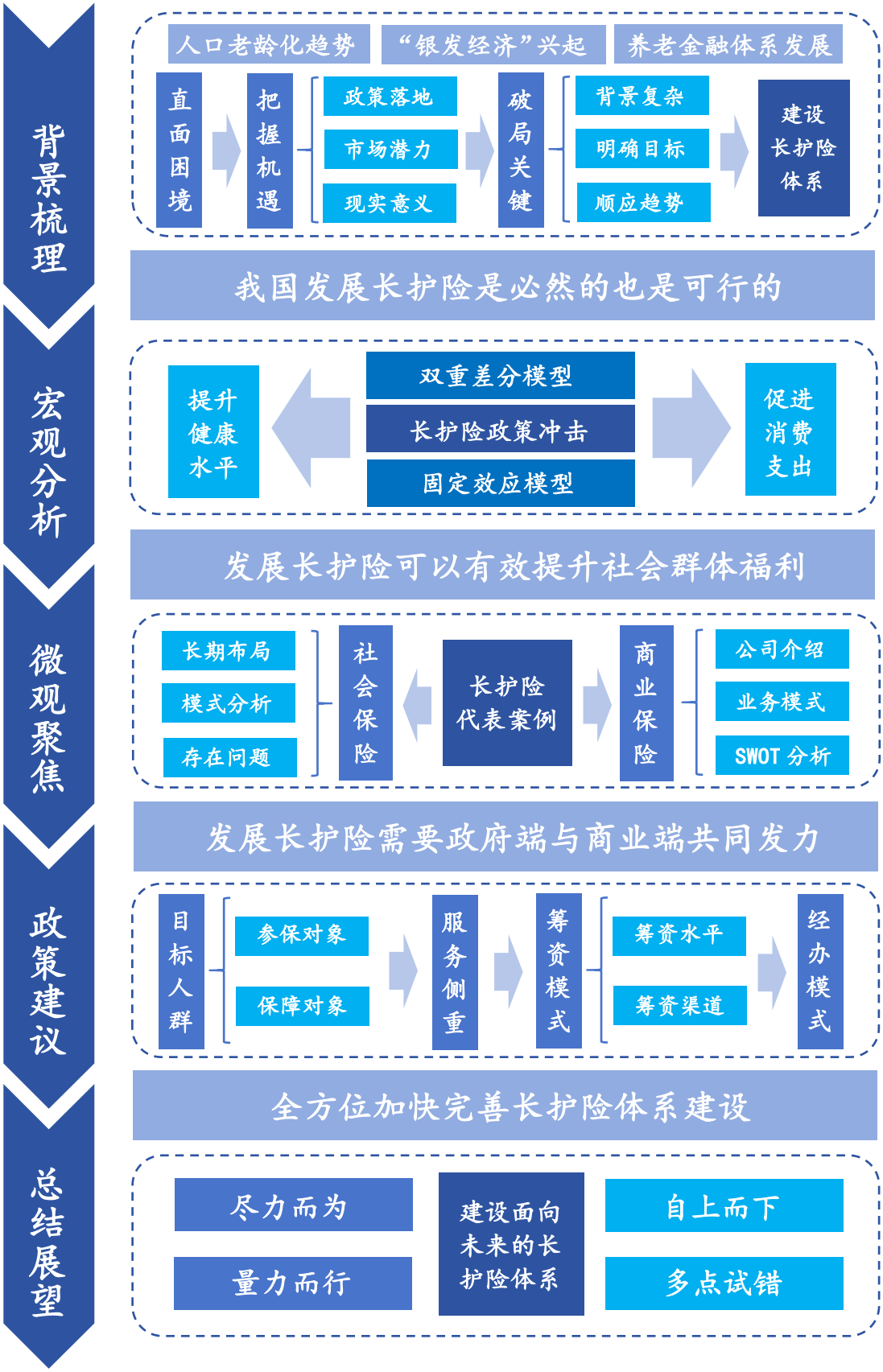
在宏观分析中，本文通过 DID 和固定效应模型等实证研究发现长护险对老年群体健康水平和家庭消费支出水平有积极影响。对老年群体健康水平影响的实证研究中，本文利用 CHARLS 数据，通过双重差分法进行模型设定和分析，包括描述性统计、平行趋势检验、基准回归和稳健性检验等，结果显示长护险政策能有效提升所在城市老年人群体健康水平。对家庭消费支出水平影响的实证研究同样采用双重差分法，结果显示长护险对家庭人均消费有正向影响。

微观聚焦我国长护险代表体系包括地方政府和商业保险两大板块。以上海市为例的地方政府长护险体系，在长期布局上涵盖多方面内容，其运行机制包括资金筹集、需求评估、提供服务、给付标准和费用结算等环节，但也存在制度设计不足、未建立统一管理信息系统和服务提供局限等问题。以中国平安为例的商业养老服务体系下的寿险业务，具有给付条件和评估标准，通过 SWOT 分析探究其所具备的优势和面临的挑战。

政策建议方面，本文提出应当确定享受待遇目标人群需考虑年龄覆盖区间、失能标准和服务侧重；筹资模式选择要确定合理筹资水平、筹资渠道和费率结构；经办模式可从政府采购向保险机构委托管理转型，并明确相关管理模式和标准。

【关键词】长期护理保险；银发经济；人口老龄化；DID 模型；固定效应模型

研究思路


背景梳理
人口老龄化趋势
“银发经济”兴起
养老金融体系发展
直面困境
把握机遇
政策落地
市场潜力
现实意义
破局关键
背景复杂
明确目标
顺应趋势
建设长护险体系
我国发展长护险是必然的也是可行的
宏观分析
提升健康水平
双重差分模型
长护险政策冲击
固定效应模型
促进消费支出
发展长护险可以有效提升社会群体福利
微观聚焦
长期布局
模式分析
存在问题
社会保险
长护险代表案例
商业保险
公司介绍
业务模式
SWOT 分析
发展长护险需要政府端与商业端共同发力
政策建议
目标人群
参保对象
保障对象
服务侧重
筹资模式
筹资水平
筹资渠道
经办模式
全方位加快完善长护险体系建设
总结展望
尽力而为
量力而行
建设面向未来的长护险体系
自上而下
多点试错

目录

研究摘要 I

研究思路 II

1 背景梳理：箭在弦上——发展老年长期护理保险势在必行 1

1.1 直面困境：中国人口的“老龄化”浪潮 2

1.2 把握机遇：“银发经济”相关产业方兴未艾 5

1.2.1 政策层面：“银发经济”顶层设计加快落地 5

1.2.2 指标层面：“银发经济”蕴藏巨大市场潜力 6

1.2.3 现实层面：“银发经济”何以回答“时代之问” 8

1.3 破局关键：加快构建新型养老金融服务体系 9

1.3.1 背景：“中国式”老龄化的复杂性与特殊性 9

1.3.2 现实：我国当前的养老金融体系亟待优化 11

1.3.3 目标：兼具民生福祉与经济运行二重目标 14

1.3.4 风向：保险行业在养老金融中的发展潜力 15

1.3.5 方案：建设长期护理保险体系 17

2 宏观分析：发展长护险对社会福利的影响分析 20

2.1 发展长护险对老年群体健康水平影响的实证研究 20

2.1.1 研究假说 20

2.1.2 数据来源与模型设定 22

2.1.3 描述性统计 23

2.1.4 平行趋势检验 24

2.1.5 基准回归 25

2.1.6 稳健性检验 25

2.2 发展长护险对家庭消费支出水平影响的实证研究 27

2.2.1 政策背景 27

2.2.2 数据选取 27

2.2.3 统计结果 27

2.2.4 识别方法 27
2.2.5 结论 29

3 微观聚焦：我国长护险代表体系的模式分析 30
3.1 地方政府长护险代表体系：以上海市为例 30
3.1.1 长期布局 30
3.1.2 模式分析 32
3.1.3 存在问题 35
3.2 商业养老服务体系下的寿险业务：以中国平安为例 36
3.2.1 公司介绍 36
3.2.2 业务模式 37
3.2.3 SWOT 分析 38

4 政策建议：加快完善长护险体系建设 47
4.1 享受待遇的目标人群的确定 47
4.1.1 参保对象覆盖：以城镇职工为主还是扩展至城乡居民？ 47
4.1.2 保障对象覆盖：窄口径模式与宽口径模式？ 49
4.2 服务侧重：以基本生活照料为主与以医疗护理为主？ 50
4.3 筹资模式选择 51
4.3.1 筹资水平 51
4.3.2 筹资渠道 53
4.4 经办模式：政府采购与保险机构委托管理 54

5 总结与展望 57

参考文献 59

图目录

图 1 我国养老体系示意图 1
图 2 2023 年中国人口年龄结构图 3
图 3 政策中包含“老龄”相关词语的文件数目 6
图 4 我国养老产业统计分类 7
图 5 中国银发经济市场规模（万亿人民币），2019-2028 预测 8
图 6 我国退休养老资金规模调查 9
图 7 我国退休资金储备调查 10
图 8 我国老年人口抚养比趋势 10
图 9 含有“养老金融”字样的政策文件发布年份分布 11
图 10 我国养老保险支出增速放缓 12
图 11 政策文件解读：银发经济相关内容四象限分布 15
图 12 养老金融产品购买渠道调查 16
图 13 平行趋势检验结果 24
图 14 安慰剂检验结果 26
图 15 上海市老年照护需求评估体系 33
图 16 中国平安发展历程 36
图 17 中国平安业态分布 37
图 18 中国平安“管理式医疗”健康生态平台 38
图 19 “平安臻享 RUN”平台 39
图 20 平安高端养老服务体系发展历程 39
图 21 方正集团主要业务及旗下主要产业 42
图 22 中国平安寿险业务营收趋势 43
图 23 试点城市筹资方式 51
图 24 定额筹资试点城市城镇职工长护险年筹资标准及渠道 52

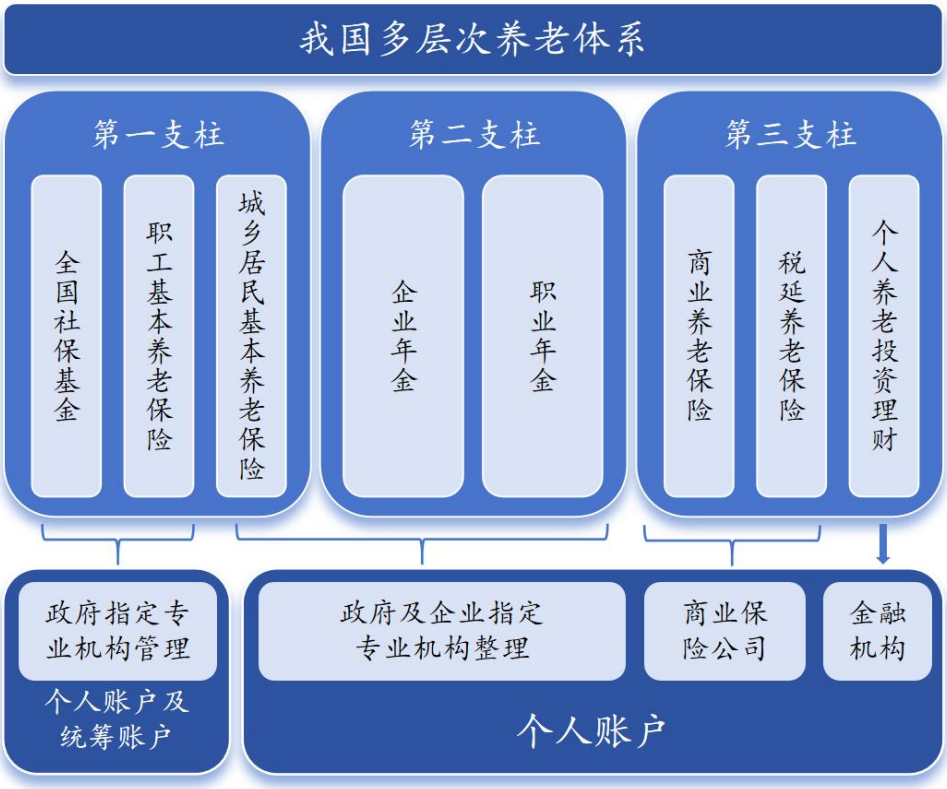
表目录

表 1 我国长护险政策时间线 5
表 2 各类关键词概念划分 14
表 3 国外长护险发展历程梳理 18
表 4 我国长护险发展历程梳理 19
表 5 变量名称即构建 23
表 6 描述性统计结果 24
表 7 基准回归结果 25
表 8 政策时点前移回归结果 26
表 9 描述性统计结果 27
表 10 回归结果 28
表 11 t 检验结果 28
表 12 上海市长护险政策梳理 31
表 13 平安臻颐年产品亮点分析 40
表 14 平安臻颐年各期保费门槛 41
表 15 长护险市场中养老社区网点规划 45
表 16 长期护理保险试点城市参保对象情况 48
表 17 长护险保障对象覆盖模式情况 49
表 18 扬州市长期护理保险居家上门照护服务项目与内容 50
表 19 长护险试点城市筹资渠道 53
表 20 长期护理保险经办模式的梳理 54
表 21 长期护理保险竞业分析 55
表 22 长期护理保险重要政策总结 57

1 背景梳理：箭在弦上——发展老年长期护理保险势在必行

中国人口老龄化正在以前所未有的速度发展。在国内人口加速老龄化、经济复苏乏力和宏观经济不确定性增加等多重挑战下，我国养老事业正呈现出家庭功能弱化、养老服务支付渠道不足、农村养老服务种类少且供给短缺、城市养老服务结构失衡等诸多问题。尤其是随着老年人口比例的持续上升，老年人对长期护理服务的依赖程度不断加深，给家庭和社会带来了巨大的压力。由于平均寿命的延长和健康老龄化尚未完全实现，老年人需要照护的生命时段同期延长，这不仅增加了个人及家庭的照护负担，也使得社会在老龄化进程中持续承压。

图 1 我国养老体系示意图



资料来源：深藏 blue 队整理

与此同时，随着社会分工的日益细化和现代家庭结构的变迁，子代对老年人的亲自照护渐趋不足，许多家庭难以承担日益增加的照护需求。随着老年人照护比的不断提高，老年照护负担也由“家庭”单位向“社会”单元层层传导。因此，如

何有效缓解长期照护压力，保障老年人福祉，成为新时代社会发展迫切需要回答的时代之问。

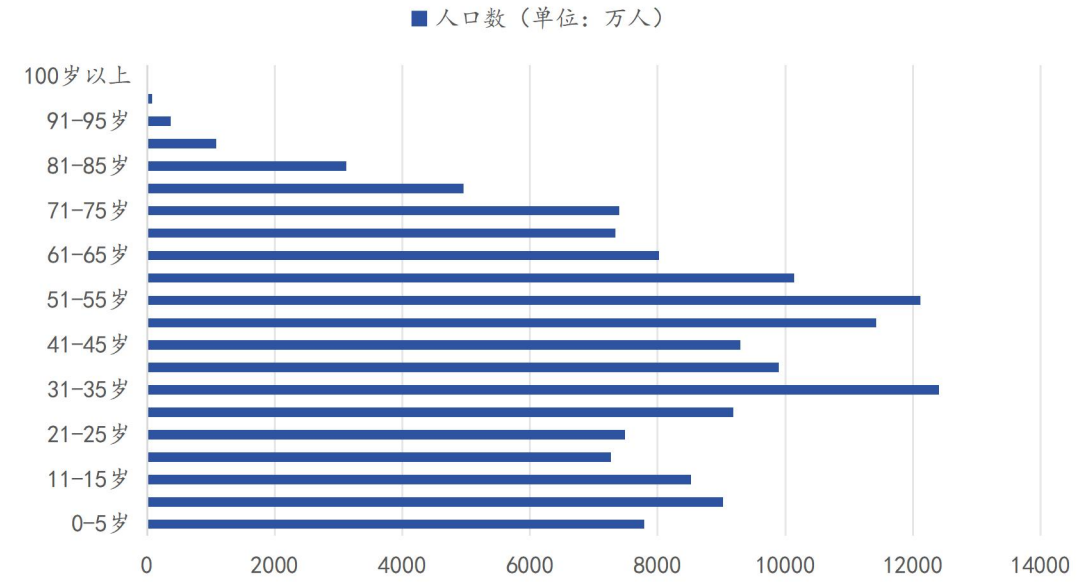
解决这一“时代之问”离不开政府、市场和社会的通力合作。随着收入更高的新一代老年人步入老龄阶段，我国老年人的平均消费能力将进一步提高，预计未来老年人的养老支付能力将随着养老需求不断增长而快速提升。因此，市场多元主体应积极参与这一进程，通过产业的有机融合，激发市场活力。纵观各类市场主体，我们发现横跨保险、健康、养老、资管等经营资质的大保险行业，在助力居民积累养老财富、发挥长期资金优势以及构建康养产业链方面拥有难以替代的独特价值与优势。其中，老年长期护理保险更是从养老产业的长期照护场景中应运而生的佼佼者。

推广长期护理保险，通过合理的保险机制，可以减轻家庭成员的照护压力，为老年人获取专业和系统的服务提供资金支持，这不仅关乎老年人的基本照护需求和生活质量，也关乎家庭幸福与和谐社会的构建。此外，发展长期护理保险对于养老金融产业的健康发展具有重要意义，不仅能够促进相关养老行业的成长，同时为经济发展注入“银发经济”新活力。现实中，随着保险市场的不断完善、政策支持的强化和试点城市的积极探索，长期护理保险的推广已具备较高的可行性。因此，长期护理保险的实施与完善，对于应对人口老龄化挑战，保障社会稳定与经济持续发展，具有显著的现实价值和深远的战略意义。

1.1 直面困境：中国人口的“老龄化”浪潮

人口老龄化是指人口生育率降低和人均寿命延长导致的总人口中因年轻人口数量减少、年长人口数量增加而导致的老年人口比例相应增长的动态。国际上通常看法是，当一个国家或地区 60 岁以上老年人口占人口总数的 10%，或 65 岁以上老年人口占人口总数的 7%，即意味着这个国家或地区的人口处于老龄化社会。2000 年，中国 65 岁及以上人口占比达到 7.0%，标志着中国正式进入人口老龄化社会。

图 2 2023 年中国人口年龄结构图



资料来源：联合国官网，深藏 blue 队整理

2022 年，国家健康委员会等部委联合印发《“十四五”健康老龄化规划》指出，我国是世界上老年人口规模最大的国家，也是世界上老龄化速度最快的国家之一。“十四五”时期（2021-2025 年），我国人口老龄化程度将进一步加深，60 岁及以上人口占总人口比例将超过 20%，进入中度老龄化社会。根据我国民政部发布《2023 年度老龄事业发展公报》数据显示，截至 2023 年末，全国 60 周岁及以上老年人口 29697 万人，占总人口的 21.1%；全国 65 周岁及以上老年人口 21676 万人，占总人口的 15.4%。全国 65 周岁及以上老年人口抚养比 22.5%。老龄化率高于全球平均水平。

回顾新中国人口结构演化人口历史，老龄化是一个动态发展过程。基于特定的国情和庞大的人口基数，中国人口老龄化呈现出“大规模”老年人口、“快速度”老龄化进程、“高水平”老龄化程度、“长稳定”老龄化形态等特征。

第一，中国老年人口规模庞大。2022 年起，我国 65 周岁及以上年龄的老年人数量已位居世界首位。截至 2023 年末，全国 65 周岁及以上老年人口为 2.17 亿人；约占全球老年人口的 26.8%，数量规模远超其他国家和地区。

第二，中国老龄化进程速度快。新中国成立以来，中国人口年龄结构发生巨大变化，目前正由年轻型转向老年型。据预测，“十四五”期间 60 岁及以上老年人口年均增长约 1000 万，远高于“十三五”期间增幅。中国 65 岁及以上老年人口占比由 7%增长到 14%仅历经 27 年，显著快于发达国家平均所需 45 年以上时间。

第三，中国老龄化程度水平高。国家统计局最新数据显示，截至 2023 年底，我国 65 岁以上老年人口达到 21676 万人，相较 2022 年增加了 698 万人，已占全国总人口数 15.4%。预计 2035 左右年我国将进入重度老龄化时代，2040 年左右老龄化水平超 30%，进入深度老龄化社会。

第四，中国老龄化呈现高原态势。据预测，中国老年人口规模及占比将在 21 世纪中叶后达到峰值水平。联合国《世界人口展望》预测表明，中国 65 岁及以上老年人口占比会在相当长一个时期内保持 30%左右的相对高位，从长期来看将稳定在“老龄化高原”之上。

在未来，中国老龄化趋势仍将延续是一个不容忽视的事实，其深远影响将触及社会、经济、文化等多个领域。随着生育率的持续下降以及人均寿命的延长，老年人口比例预计将在未来继续上升。据联合国预测，我国 65 岁以上人口占比将在未来 60 年攀升至 40%以上。这一变化不仅意味着对养老服务和医疗保健系统的需求将大幅增加，同时也将对整体经济运行产生重大影响。

面向未来，国务院发布的《“十四五”国家老龄事业发展和养老服务体系规划》中指出，我国老年人口规模大，老龄化速度快，老年人需求结构正在从生存型向发展型转变。面对人口老龄化，国家顶层设计强调了实施积极应对人口老龄化国家战略，推动老龄事业和产业协同发展的重要性和紧迫性，发展银发经济成为时代的题中之义。

1.2 把握机遇：“银发经济”相关产业方兴未艾

1.2.1 政策层面：“银发经济”顶层设计加快落地

2024 年 1 月 15 日，国务院办公厅发布《关于发展银发经济增进老年人福祉的意见》。作为国家层面发布的首个支持银发经济发展专门文件，《意见》指出，“银发经济”是向老年人提供产品或服务，以及为老龄阶段做准备等一系列经济活动的总和，涉及面广、产业链长、业态多元、潜力巨大。这也是“银发经济”首次被清晰地定义。

同时，《意见》提出了“以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，坚持以人民为中心的发展思想，实施积极应对人口老龄化国家战略，坚持尽力而为、量力而行，加快银发经济规模化、标准化、集群化、品牌化发展，培育高精尖产品和高品质服务模式，让老年人共享发展成果、安享幸福晚年，不断实现人民对美好生活的向往”的总体目标。

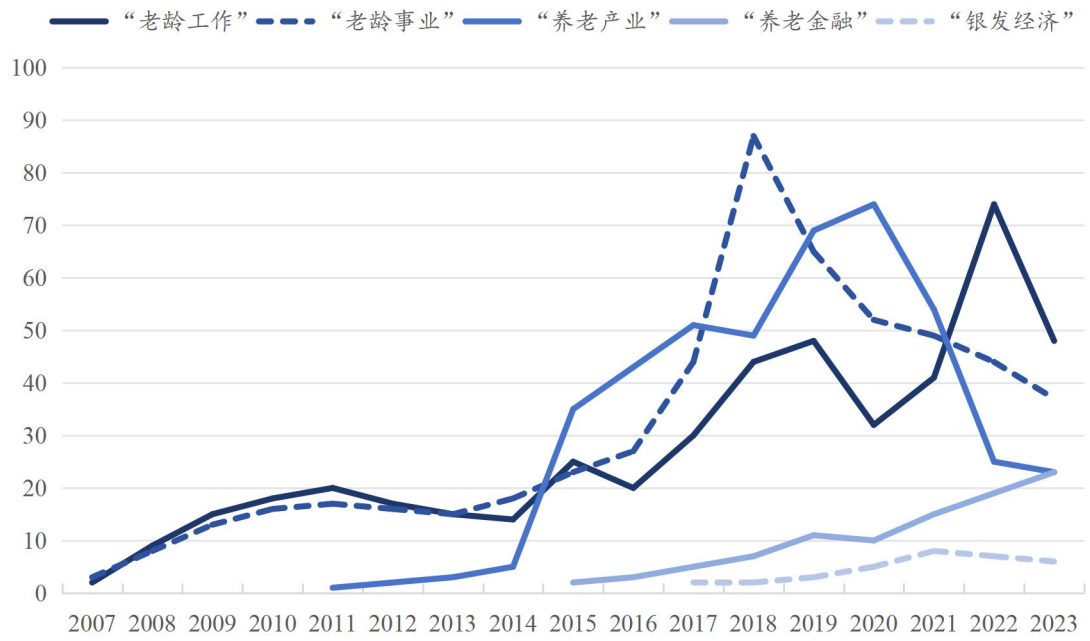
表 1 我国老龄工作相关政策时间线

时间	内容
2019 年 11 月	中共中央、国务院印发了《国家积极应对人口老龄化中长期规划》，是到本世纪中叶我国积极应对人口老龄化的战略性、综合性、指导性文件，从国家战略层面确立了中长期应对人口老龄化的全方位部署和安排。
2020 年 11 月	2020 年 11 月，党的十九届五中全会通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二 0 三五年远景目标的建议》明确提出，“实施积极应对人口老龄化国家战略”，要求以“一老一小”为重点完善人口服务体系。
2021 年 5 月	《中共中央国务院关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》公布，从优化生育政策、实施一对夫妻可以生育三个子女政策和配套积极生育支持措施等多个方面，促进人口长期均衡发展。
2021 年 11 月	中共中央、国务院印发了《关于加强新时代老龄工作的意见》，提出要健全养老服务体系，完善老年人健康支撑体系，积极培育银发经济。
2022 年 2 月	国务院印发《“十四五”国家老龄事业发展和养老服务体系规划》，围绕推动老龄事业和产业协同发展、推动养老服务体系高质量发展，明确了“十四五”时期的总体要求、主要目标和工作任务。
2023 年 5 月	中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于推进基本养老服务体系建设的意见》，用清单化、项目化的方式，将基本养老服务作为公共产品向全体老年人提供，是我国养老服务体系建设的一项创新。

资料来源：国务院官网，深藏 blue 队整理

在总体目标指引下，《意见》提出“发展民生事业，解决急难愁盼”“扩大产品供给，提升质量水平”“聚焦多样化需求，培育潜力产业”和“强化要素保障，优化发展环境”三大方向，从“民生导向”“供给水平”“产业培育”和“发展保障”角度为银发经济发展进行顶层设计。

图 3 政策中包含“老龄”相关词语的文件数目



资料来源：平安证券研究所，深藏 blue 队整理

1.2.2 指标层面：“银发经济”蕴藏巨大市场潜力

2023 年，中国“银发经济”市场规模已然高达 7.1 万亿人民币，展现出其蓬勃的发展态势。从供给与需求的相互作用视角剖析，老年人呈现出多样化的养老需求，这种需求成为了各类养老相关产业兴起与发展的重要驱动力。深入探究这一现象的内在逻辑，随着社会结构的深刻变革以及家庭关系的持续变迁，老人依赖子女支持与照料的传统养老模式，在可持续性和可实现性方面遭遇了双重挑战，进而不断地被“解构”。在此背景下，传统家庭养老模式正逐步向多元化、专业化程度更高的养老服务模式进行演进，这一演变过程对整个社会养老体系产生了深远影响。

传统“家庭模式”受到现代生活冲击，面临严峻挑战。不过，这却为“银发经济”创造了发展空间与机遇。养老产业积极适应变化，推动养老需求供给朝着社会化、规模化方向发展。专业化老年用品大量涌现，满足老年人特殊需求；智慧健康管理服务借助科技力量，精准守护老人健康；养老社区等新兴模式蓬勃兴起，为老人营造优质生活环境。这些新兴产业为养老产业发展带来了不可小觑的市场机遇，开启了养老产业的新篇章。

图 4 我国养老产业统计分类

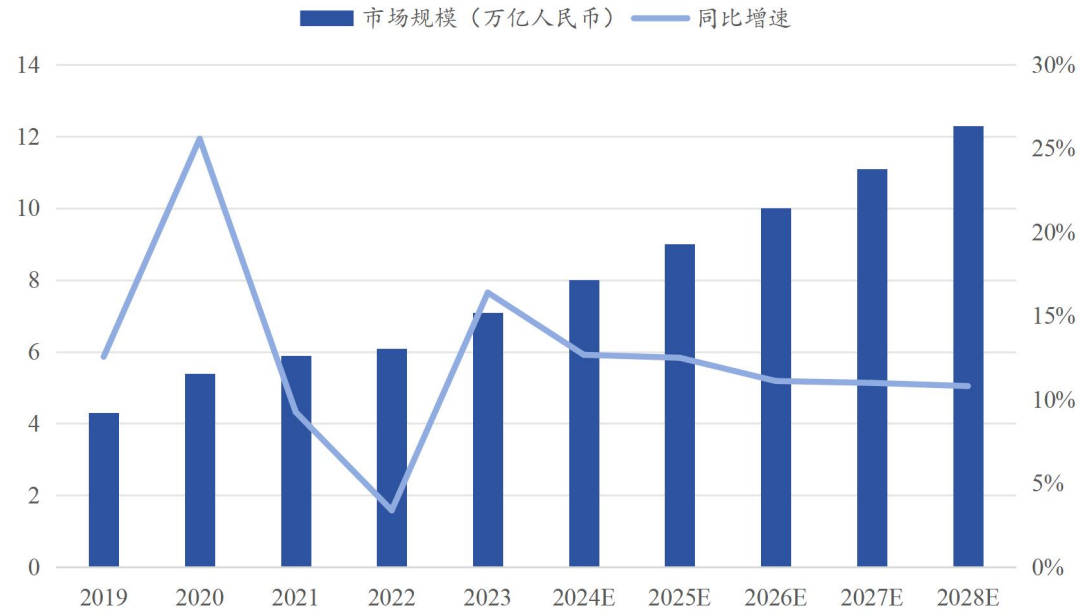


资料来源：深藏 blue 队整理

其次，政府对养老产业的支持和投入也在不断增加，这激发了市场供给的活力，促进了养老产业的规模化和专业化发展。政府的政策扶持，如加大对养老服务业的金融支持、推动养老产业集聚发展等举措，为行业的健康发展提供了坚实保障。

老龄化进程的加速，叠加政策支持的强化，银发经济市场迎来了蓬勃发展的活力。目前，我国的银发经济作为涉及多种业态，跨多元产业，拥有着壮大的产业链，覆盖了从基本生活、康养保健、养老服务、休闲娱乐到智能科技等多个领域，是一个充满活力和潜力的新兴经济形态。近年来，中国银发经济市场规模呈现出迅速扩张态势的趋势。自 2019 年至 2023 年，市场以每年约 13.2%的复合年增长率增长。

图 5 中国银发经济市场规模（万亿人民币），2019-2028 预测



资料来源：国信证券，深藏 blue 队整理

未来，随着产业的不断成熟和政策的进一步优化，银发经济市场规模必将继续保持较高增长。预计到 2028 年，市场规模将达到 12.3 万亿人民币，复合年增长率约为 11.8%。这表明，银发经济产业具有巨大的发展潜力，将成为中国经济的重要增长引擎。

1.2.3 现实层面：“银发经济”何以回答“时代之问”

《意见》指出要实施积极应对人口老龄化国家战略，以老年群体需求为基础，大力发展银发经济，加快银发经济规模化、标准化、集群化、品牌化发展，满足老年群众多方面需求，妥善解决人口老龄化带来的社会问题，培育经济发展新动能，提高人民生活品质，增进老年人福祉，不断实现人民对美好生活的向往。

银发经济的扩展促进了新兴产业和就业机会的增长，如养老服务、健康管理、休闲旅游等领域的发展，产业发展和就业增加为经济增长注入了新动力。同时，这也推动了技术创新和应用，尤其是在智能科技、生物医药、远程医疗等新兴领域，加速了前沿科技的重大突破和产业结构的优化升级。

银发经济的兴起反映了社会对于老年人的价值重估，不再仅将老年人视为经济负担，而是认识到他们对社会的贡献以及他们作为消费者的潜力。这一观念的转变有利于增进银发群体的精神福祉，助力构建更加和谐、公平、可持续发展的社会。

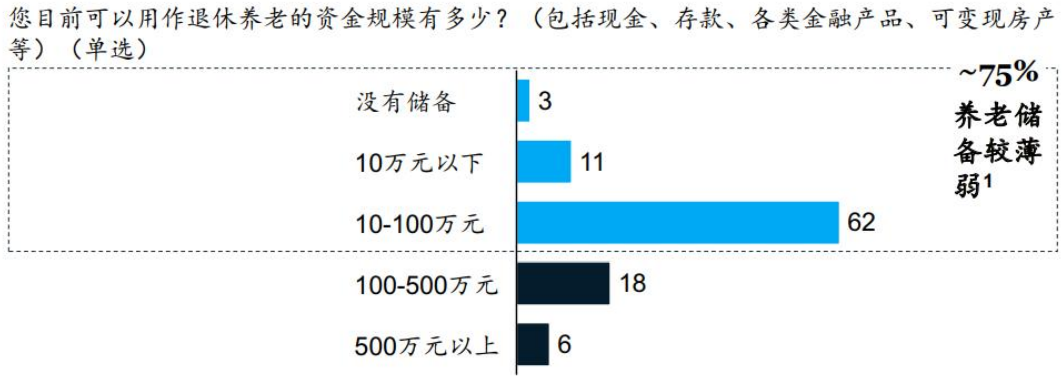
1.3 破局关键：加快构建新型养老金融服务体系

1.3.1 背景："中国式"老龄化的复杂性与特殊性

（1）未富先老，经济实力基础不足。

通常，发达国家是在经济高速发展和物质财富充分积累的基础上进入老龄化社会，国家已经拥有足够的物质条件和充沛的经济基础解决养老问题；而中国在2000 年进入老龄化社会时人均 GDP 约为 900 美元，是明显在经济尚不发达情况下提前进入老龄社会，因而解决养老问题缺乏较为充裕的物质基础。

图 6 我国退休养老资金规模调查

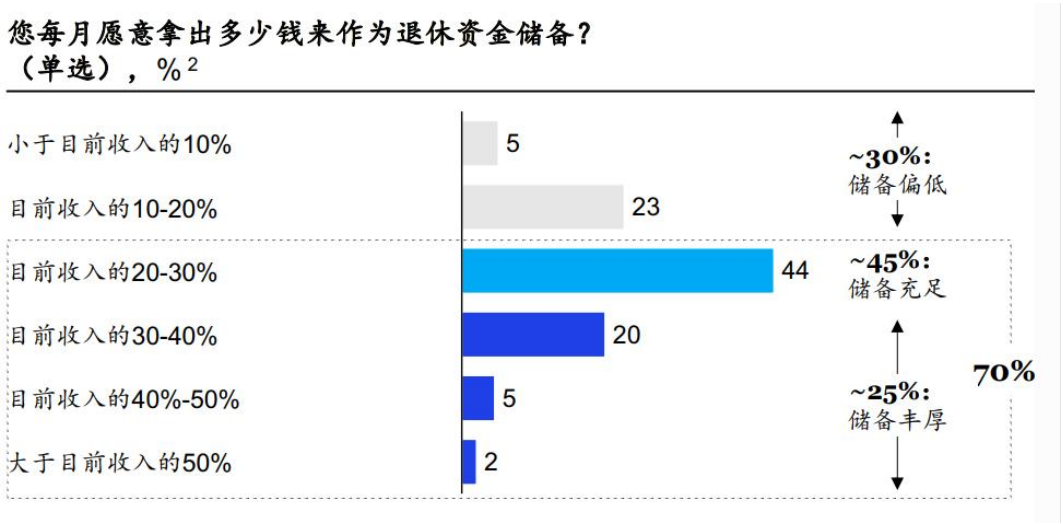


资料来源：麦肯锡，深藏 blue 队整理

（2）未备先老，养老财富储备不足。

中国进入人口老龄化时，存在人力、物力、财力、认识和制度等准备不足的情况。以养老资产储备为例，目前各支柱养老资产储备占比不足同期GDP的10%；而经济合作与发展组织（OECD）国家 2020 年的退休储蓄计划资产占 GDP 的比重已达 26.6%。

图 7 我国退休资金储备调查

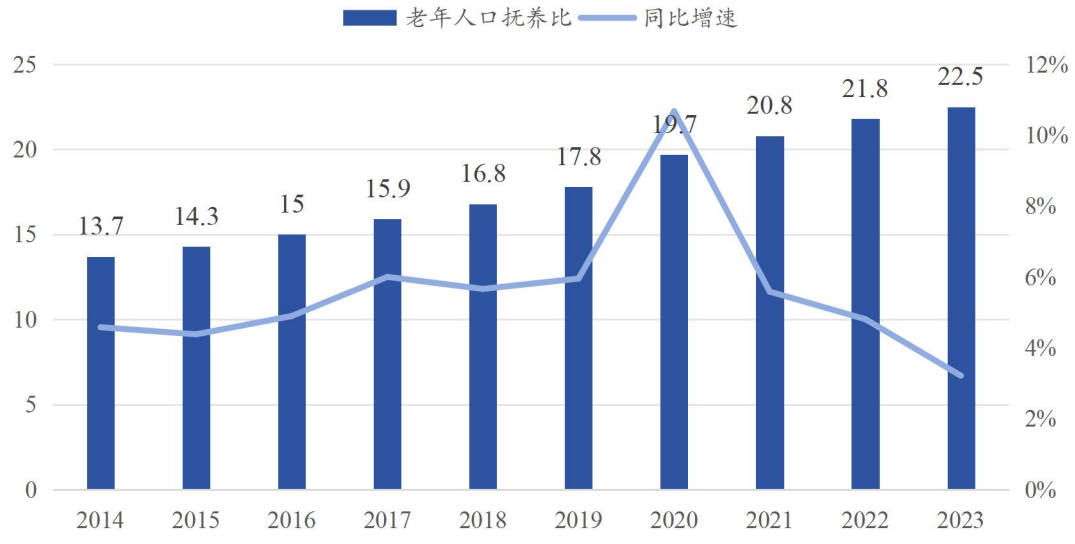


资料来源：麦肯锡，深藏 blue 队整理

（3）照护短缺，家庭支持力量弱化。

受计划生育政策和人口迁移流动等因素影响，中国平均家庭户规模持续小型化。第七次全国人口普查数据显示，2020 年平均每个家庭户的人口为 2.62 人，比 2010 年的 3.10 人减少 0.48 人。家庭户规模继续缩小，传统家庭照料功能不断弱化，家庭照护支撑力量不足，养老问题由家庭外溢至社会的倾向愈加明显。

图 8 我国老年人口抚养比趋势

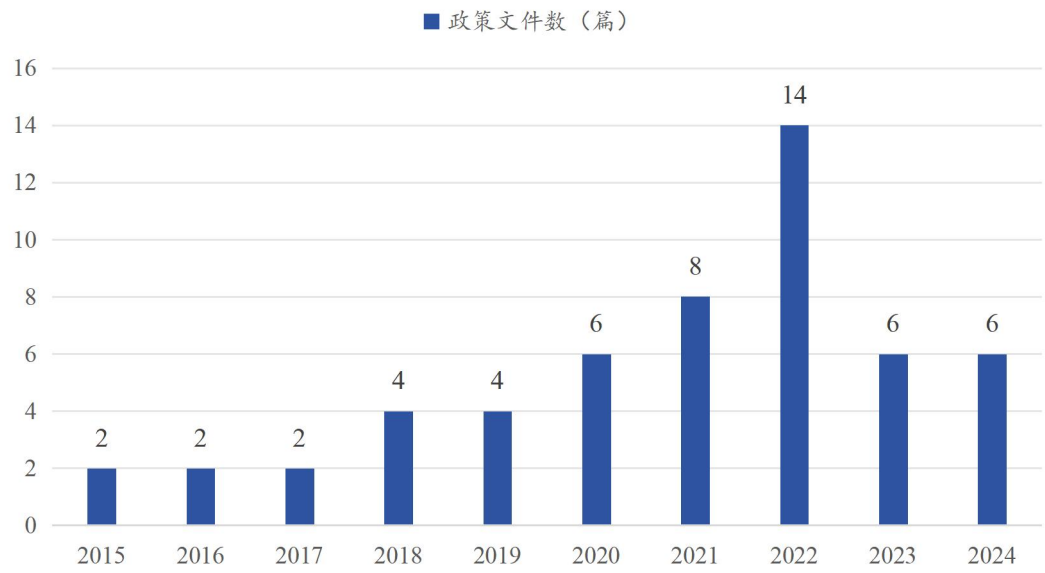


来源：国家统计局，深藏 blue 队整理

（4）服务薄弱，服务供给存在缺口。

我国社区居家养老服务存在政策碎片化与精准性问题突出、需求多样化与供给单一化矛盾突出以及养老服务融资困难等问题，机构养老面临资源利用率不高、自我发展能力不强等挑战。整体来看，养老服务发展不平衡不充分、有效供给不足、服务质量不高等问题依然存在，群众多样化的养老服务需求尚未得到有效满足。

图 9 含有“养老金融”字样的政策文件发布年份分布



来源：平安证券，深藏 blue 队整理

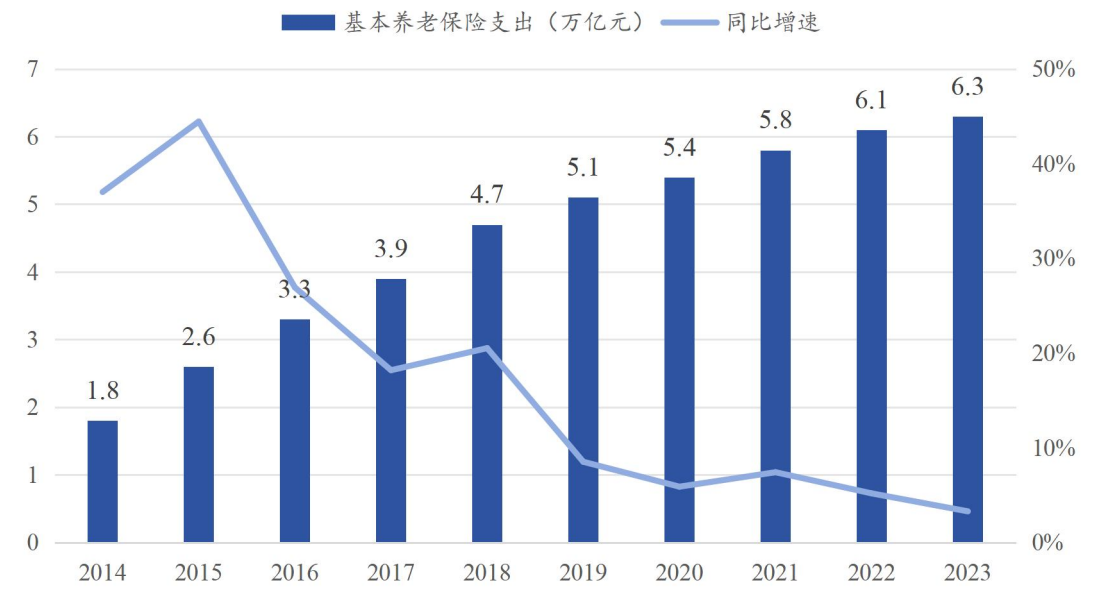
1.3.2 现实：我国当前的养老金融体系亟待优化

（1）养老金“三大支柱”失衡。

目前我国养老保险体系由“三大支柱”组成，第一支柱是基本养老保险，包括职工基本养老保险和城乡居民基本养老保险，采取社会统筹与个人账户相结合的制度模式，由国家、用人单位(集体)和个人共同承担，发挥保基本、兜底线的功能;第二支柱是企业年金和职业年金，由用人单位和职工个人共同缴费，采取个人账户方式管理，实行完全积累;第三支柱是个人储蓄性养老保险和商业养老保险，具体包括个人养老金和其他个人商业养老金融业务两个部分。

“三大支柱”共同构建了当前我国多层次、多支柱的养老保险体系，但体系内部也存在一定结构性失衡。截至 2022 年底，我国第一支柱（基础养老金）资金结余约有 9.59 万亿元，占三支柱总比例约 66%，承担了主要保障责任，覆盖近 11 亿人，但支出方面日益承压，替代率呈现下降趋势，目前已降至 45%，低于国际劳工组织 55%的警戒线水平；第二支柱中有实力负担企业年金/职业年金的企业总数规模较小，总资金约有 4.98 万亿元，占比约 34%；第三支柱尚处于起步阶段，发展缓慢，占比过低，对养老保障的支撑作用明显不足。尤其是目前我国“第三支柱”正处于起步阶段，累计规模非常有限。总结来看，我国养老金市场整体呈现出第一支柱承受压力过大，第二、第三支柱发展动力不足，进展缓慢的特点，这一现状在加重了政府的财政负担的同时，也不利于我国养老事业的健康可持续发展。

图 10 我国养老保险支出增速放缓



来源：Choice，深藏 blue 队整理

（2）养老金存在“缺口”隐患。

2019 年，中国社科院世界社保研究中心发布的《中国养老金精算报告 2019 - 2050》做出了极具前瞻性的预测。在老龄化进程加速这一宏观背景下，我国城镇企业职工基本养老保险基金累计结余将于 2027 年达到峰值，数额为 6.99 亿元。以此为依据进行进一步估算，我国每年基本养老保险费收取与支出之间的“缺口”

在 2050 年预计将占据 GDP 的 5.5%。

以 OECD 国家作为参照进行对比分析，在其养老金体系的三支柱中，第二、三支柱占 GDP 比例的算术平均数高达 55.3%。然而，我国在这方面的比例仅约为 1%。这种鲜明的对比充分表明，当前我国在养老金来源方面，对基本养老保险基金以及政府的依赖程度较重，反映出我国养老金体系结构与国际上部分发达国家之间存在的显著差异，也凸显了我国养老金体系优化调整的紧迫性。

当前，在我国的基本养老保险体系中，社会统筹账户遵循现收现付制运行，其核心机制表现为在职人员缴纳的费用直接用于支付当期已退休人员所应得的养老金。然而，受养老金改革等复杂因素的综合作用，在实际领取养老金的老年人群体中，存在相当一部分人在其“在职”生命时段内并未向社会统筹账户履行缴费义务。随着社会老龄化进程的持续加快，养老需求呈现出不断攀升的趋势，在此背景下，养老金积累过程中出现缺口的隐患逐渐凸显。

除此之外，现阶段我国养老金融体系仍处于发展完善阶段，尚未达到完全成熟的状态。这就导致在短时间内，若要引入大规模社会资本以充实养老金储备，会面临诸多现实层面的困难。这些困难进一步加剧了养老金积累缺口所带来的潜在风险，使得整个养老金体系的稳定性面临更为严峻的挑战。

（3）养老金融产品供给不足兼有“同质”之忧。

在人口老龄化大背景下，目前金融机构能够提供的相应产品相对不足。据《2020 年新发行养老理财产品分析报告》数据统计，2020 年市场上共发行 64228 款银行理财产品，养老型理财产品仅有 149 款，占比不足 1%。同时，养老金融产品设计开发本土化不足，少有因地制宜结合国情做结合变通。以住房反向抵押贷款为例，受产品自身风险和我国居民安土重迁思想影响，在国内市场推进阻力较大，消费者反响欠佳。此外，市场上推出的养老服务产品存在同质化现象，大多是大众金融理财产品，中长期养老服务产品相对缺乏，难以实现以时间换空间进而实现长期效益支持长期护理的目标。

表 2 各类关键词概念划分

	在政策文件中的典型使用方式	示例文件	在政策文件中的主要内涵
老龄工作	作为标题出现	《中共中央、国务院关于加强新时代老龄工作的意见》	所有涉及老年人的政府工作。
老龄事业	积极应对人口老龄化国家战略，推动老龄事业和产业协同发展	《“十四五”国家老龄事业发展和养老服务体系规划》	非盈利，主要满足老年人基本需求的相关活动。
老龄产业			盈利，满足老年人各类需求的相关活动。
养老服务	兜底性、普惠型、多样化的养老服务体系/居家社区机构相协调、医养康养相结合的养老服务体系	《“十四五”国家老龄事业发展和养老服务体系规划》/《中共中央、国务院关于加强新时代老龄工作的意见》	盈利与非盈利，满足老年人各类需求的服务。当前重点在非盈利。
老年用品			盈利，满足老年人各类需求的货物。实际就是养老商品。
养老产业	推动养老事业和产业协同发展	《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》	盈利，满足老年人各类需求的相关活动。
养老金融	支持金融机构依法合规发展养老金融业务，提供养老财务规划、资金管理等服务。	《国务院办公厅关于发展银发经济增进老年人福祉的意见》	盈利，直接为老年人提供经济支持的金融活动。
	养老金融产品更加丰富，对银发经济、健康和养老产业的金融支持力度持续加大，更好满足养老金融需求。	《国家金融监督管理总局关于银行业保险业做好金融“五篇大文章”的指导意见》	盈利，直接或间接为老年人提供支持的金融活动(金融监管总局层面)。

资料来源：深藏 blue 队整理

1.3.3 目标：兼具民生福祉与经济运行二重目标

（1）推动养老事业高质量发展，满足人民群众多样化需求。

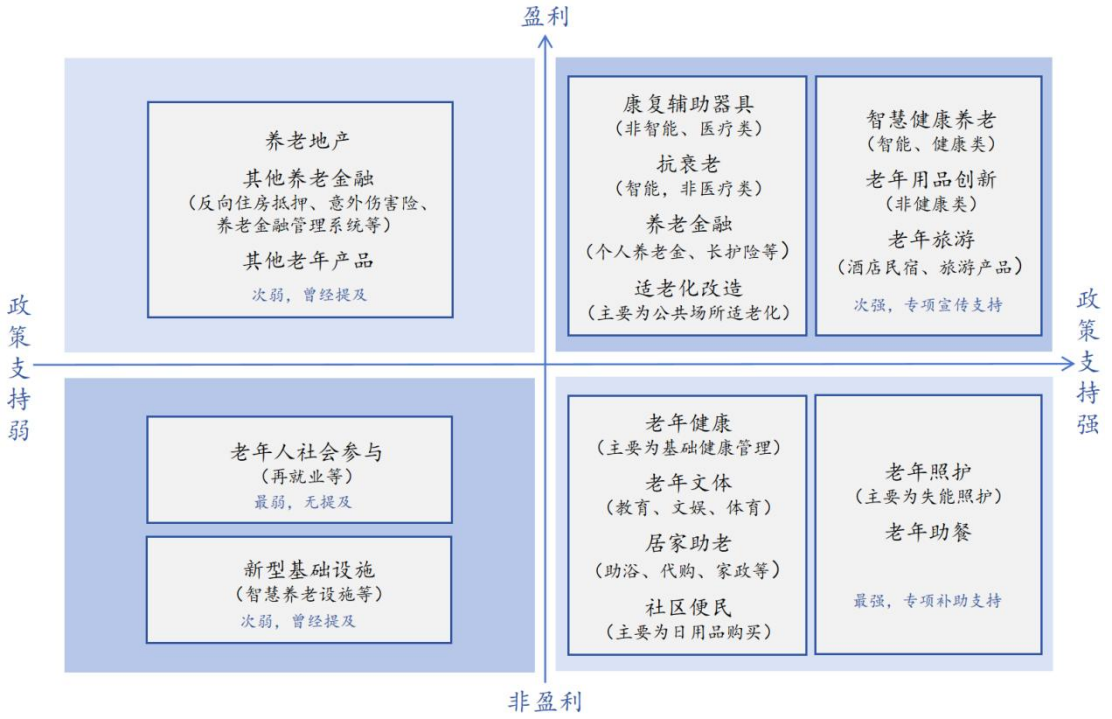
建立完善的养老金制度并通过市场化运作实现养老资金保值增值，有助于实现养老金体系可持续发展，提高老年收入水平，保障群众养老安全，增进民生福祉。另一方面，有助于创新养老金融服务、丰富养老金融产品，有效解决供需矛盾，满足群众多元需求。同时可为养老产业提供投融资支持，推动养老产业实现规模化发展，兼有发展产业经济和吸纳劳动力就业的二重利好。

（2）促进金融市场完善和成熟，推动国家经济结构转型。

养老资金作为长期资金进入金融市场，成为资本市场的重要投资者，有利于扩大金融市场规模，驱动金融市场成熟化，同时能够支持实体经济发展，间接推

动产业创新升级。同时，通过储蓄养老向投资养老的转变，有利于增强居民消费动力和优化国家金融结构，推动经济结构转型。

图 11 政策文件解读：银发经济相关内容四象限分布



资料来源：深藏 blue 队整理

（3）实现应对人口老龄化和促进经济社会发展有效结合。

通过发展养老金融解决养老资金保值增值和养老产业融资投资问题，有利于完善国家政策体系，减轻财政在养老经济保障和服务保障方面的压力。此外，通过金融与其他政策间的有效配合，实现养老保障的多渠道供给，凝聚形成制度合力，有助于系统性地解决群众养老问题，推动养老事业全面协调可持续发展。

1.3.4 风向：保险行业在养老金融中的发展潜力

（1）保险业促进养老产融结合作用突出

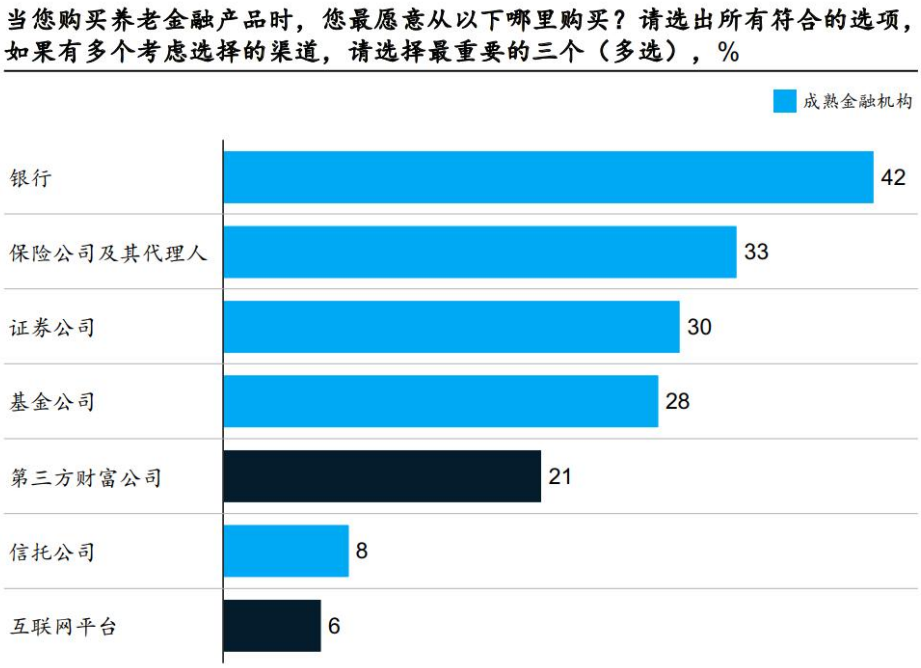
保险业与养老产业具有显著的契合优势，保险公司资金规模大、期限长，与养老产业具有天然一致性，在“保险+养老”商业模式和养老产业链整合等方面具有比较优势：一方面，基于保险公司的资本优势和经营寿险业务的“带客优势”，

保险公司将保险业务、资产管理与养老服务相融合，能充分地满足老年群体的多元化需求。另一方面，保险公司兼具保险服务和资金融通功能，能够实现对医疗康养、养老设备等养老产业链上下游的整合，基于其技术、专业和信息等优势提升养老服务质量，助推养老产业发展。例如，中国人寿、泰康保险等综合性金融保险集团纷纷涉足养老产业，通过持续投资和运营探索打造体系化医养服务平台和多层次养老社区。综合来看，保险业在拓宽养老产业融资渠道、进行风险分散和管理以及对接养老领域资金的市场需求与供给中发挥着不可替代的作用。

（2）保险是养老服务金融产品的重要形态

2024 年 1 月发布的《关于发展银发经济增进老年人福祉的意见》提出，支持金融机构依法合规发展养老金融业务，提供养老财务规划、资金管理等服务。丰富个人养老金产品，推进专属商业养老保险发展。积极发展商业医疗保险和商业长期护理保险，开展人寿保险与长期护理保险责任转换业务试点工作，加强养老金融产品研发与健康、养老照护等服务衔接。商业养老保险兼具长期储蓄和长寿风险管理功能，能够与基本养老保险紧密衔接，是重要的补充养老手段。

图 12 养老金融产品购买渠道调查



资料来源：麦肯锡，深藏 blue 队整理

数据显示，目前商业保险年金已超过 6 万亿元，覆盖 9700 万人，为 11%的中青年人提供补充养老保障；2021 年 6 月启动试点的专属商业养老保险目前保单件数约 74 万件，积累的养老准备金超过 106 亿元。其中，新产业、新业态从业人员和灵活就业人员投保超过 8 万件，件均养老准备金超过 4000 元；养老保险公司的商业养老金试点探索将养老规划、账户管理与保险产品相结合，试点一年来，已累计开户超过 59 万个；在个人养老金业务中，目前在售的个人养老金保险产品超过 30 个。在针对老年人的保障类产品方面，金融监管总局数据显示，老年人意外伤害保险产品，为广大老年人群体提供风险保障超过 3000 亿元；健康险方面，截至目前，60 岁以上人群购买的保费占比超过 5%；长护险方面，推进寿险责任与护理保险责任转换试点，探索利用存量寿险产品开展转换业务，提升长期护理保险支付能力。推进将商业长期护理保险纳入税优健康保险范畴，提升商业长期护理保险吸引力。同时，在“保险+养老社区”的模式下，截至目前，保险公司已建成运营养老社区 30 多个，运营床位超过 2.8 万张。

（3）在银发经济的巨大市场中，保险业还有很大的发展空间

在银发经济的巨大市场中，保险业仍是“蓝海”一片，在目前的基础上具有稳健的上升趋势和长远发展空间。例如，在老年医疗险方面，从精算与产品价格的平衡角度来说，老年医疗险对于保险公司来说有不小挑战，尤其是对于数量不少的慢性病老年群体而言，可选择的产品仍然不多。从目前市场上来看，一般情况下不限定健康状况的惠民保业务反而成为了老年医疗险的“主力”。在老年医疗险未来的探索中，保险机构可以着重针对老年人的特病特药、特殊治疗、长期照护和失能群体照护等特殊需求开发适合的商业保险产品。以长期护险保险为例，目前政策性长护险已在全国 49 个城市试点，但商业长护险的发展相对较为薄弱。

1.3.5 方案：建设长期护理保险体系

长期护理保险是指对个体由于年老、疾病或伤残导致生活不能自理，需要在家中或疗养院治病医疗由专人陪护所产生的费用进行支付的保险。长期护理保险属于健康保险范畴，标的物为个体的身体健康状况。通常护理期限较长，可能为

半年、一年、几年甚至十几年，护理的意义在于尽可能长的维持个体的身体机能而不是以治愈为主要目的，长期护理保险可以作为对护理费用的经济补偿。

表 3 国外长护险发展历程梳理

国家	时间	发展历程及特点	具体内容及作用
美国	20 世纪 70 年代	长护险在美国诞生	初创时期，相关产品只涵盖疗养院提供的护理服务
	20 世纪 80 年代中后期	保险公司开始以附加险形式或将其作为保单一项基本责任	为居家和社区护理提供有限保障
	20 世纪 90 年代	非常流行	涵盖更广泛的业务
	2006 年	颁布《养老金保护法案》	提高长护险税收待遇，并允许发展混合型产品
	2020 年	美国长护险保费收入达 102 亿美元左右，在世界各国排名首位	
德国	1995 年	建立社会长护险制度	德国人从工作第一天起，就要交纳护理保险，个人、公司、政府和社会救助等按不同比例承担。年老后，凭专业医生评估，德国老人被分成三个等级，自理、半自理与完全不能自理，获得不同等级的保险金。
	2019 年	约 88%的德国居民投保了社保长护险，11%的居民购买了强制性的商业长护险，以上两项强制性制度安排实现了长护险在德国社会的全覆盖。	
荷兰	2015 年	开展长护险改革，长护服务发展重心由被过度利用的机构护理转向居家护理	原长护险法案《特殊医疗费用支出法》准入宽松、覆盖广泛，而针对机构护理重新颁布的长护险法案对机构护理待遇资格采取了严格的限制，提高了入住机构的失能程度要求，机构护理待遇仅限于需 24 小时监护的中重度失能人群。
日本	2000 年	确立长护险制度	规定仅中重度失能人员(即达到“要护理”1~5 级的人员)可获得机构护理待遇
	2005 年	开展初步改革，规定接收机构护理的失能老人自行负担食宿费用	机构床位同步减少，居家护理人数增长 4 倍；支出方面，机构护理支出占比显著下降，居家护理支出占比上升至 50%，社区护理支出占比高达 17.1%，限定机构护理待遇资格策略在优化服务结构方面发挥重要作用。

资料来源：深藏 blue 队整理

长期护理险所提供的保障主要聚焦于支付老年人在日常生活中所需的照顾费用，这其中既涵盖了因自然衰老而产生的日常照顾开销，也包括由于疾病或伤残所引发的各类日常照顾费用。在实际的保障实施过程中，可分为家庭照料和机构照料这两种主要形式。家庭照料主要是依靠家人、亲属或者专业的居家护理人员为老年人提供日常的生活照顾，包括协助老人进行饮食、洗漱、穿衣等基本生活活动。机构照料则是将老年人安置在专业的养老机构或护理机构中，由专业的

护理人员为其提供全方位的照顾服务，包括医疗监护、康复护理、心理疏导等。

长期护理险与医疗险有着明显的区别。医疗险的核心保障在于支付因疾病或意外所产生的医疗治疗所需要的费用，涵盖了诊断费、治疗费、手术费、药品费等各个方面。其目的是确保患者能够获得及时有效的医疗救治，以恢复健康或控制病情。而长期护理险主要用于保障一般生活照料所支付的费用，重点关注老年人在日常生活中的护理需求，而非医疗介入。例如，长期护理险可以支付护理人员的工资、护理用品的费用、康复器材的租赁费用等，但通常不包括医疗治疗过程中的费用，如医生的诊疗费、药品的费用、手术的费用等。这种明确的区分使得两种保险在保障范围和保障目的上各有侧重，为人们提供了更加全面和针对性的保障选择。

表 4 我国长护险发展历程梳理

时间	主管部门	政策文件	发展历程
2016 年 6 月	人力资源和社会保障部	《人力资源社会保障部办公厅关于开展长期护理保险制度试点的指导意见》	提出开展长期护理保险制度试点工作的原则性要求，明确河北省承德市、吉林省长春市、黑龙江省齐齐哈尔市等 15 个城市作为试点城市。
标志着国家层面推进全民护理保险制度建设与发展的启动			
2019 年 6 月底			青岛等 15 个首批试点城市和吉林、山东两个重点联系省的参保人数达 8854 万人，42.6 万人享受待遇。
2020 年 5 月	国家医疗保障局	《关于扩大长期护理保险制度试点的指导意见》(征求意见稿)	提出扩大试点范围，拟在原来 15 个试点城市的基础上，按照每省 1 个试点城市的原则，试点范围扩充为 29 个城市，试点期限两年。
2020 年 9 月	国家医疗保障局 财政部	《关于扩大长期护理保险制度试点的指导意见》	经国务院同意，长期护理保险试点城市增至 49 个。
2024 年 7 月 25 日	国家医疗保障局	《2023 年全国医疗保障事业发展统计公报》	公报显示，去年长期护理保险试点稳步推进，异地就医人次持续增加，达 2.43 亿人次，医疗救助托底功能持续增强。
2024 年 9 月 25 至 9 月 26 日	国家医疗保障局		全国高质量推进建立长期护理保险制度培训班在滨州举办。
标志着历时 8 年的长护险试点工作落幕，长护险制度建设将在全国推开			

资料来源：深藏 blue 队整理

2 宏观分析：发展长护险对社会福利的影响分析

2016 年，人社部印发《关于开展长期护理保险制度试点的指导意见》，在 15 个城市正式试点长期护理保险制度。2020 年，国家医保局、财政部发布《关于扩大长期护理保险制度试点的指导意见》，进一步深入推进试点工作，在原有 15 个试点城市及吉林、山东 2 个重点联系省份的基础上，新增 14 个试点城市，试点期限 2 年。2016 年作为第一期试点，具有更强的外部冲击，且数据更加丰富。为了验证长护险政策的效应，在本模块将重点分析发展长护险对老年群体健康水平和家庭消费的影响。

2.1 发展长护险对老年群体健康水平影响的实证研究

2.1.1 研究假说

根据现有广泛而深入的研究成果，长期护理保险极有可能通过以下四个关键途径对人们的健康水平产生深远影响：

（1）长期护理服务

对于处于同一失能等级的老年人而言，长期护理服务的实际使用情况存在显著差异。众多研究清晰地表明，在不同的医保类别之下，职工医保的参保者在长期护理费用方面能够享有更为出色的风险保护。例如，当面临高额的长期护理费用支出时，职工医保能够在一定程度上为参保者承担大部分费用，从而减轻其经济负担。这种优势使得职工医保参保者在获取长期护理服务时更加从容，也在一定程度上为提升参保者的健康水平奠定了坚实基础。因为及时、有效的长期护理服务可以帮助失能老人更好地进行日常生活活动，减少因失能带来的并发症风险，进而促进身体健康的恢复和维持。

（2）健康行为

长期护理保险对于健康行为的影响具有明显的双重性。一方面，保险的存在可能引发道德风险问题。参保者在得知保险能够覆盖部分甚至全部长期护理费用后，可能会产生一种依赖心理，从而增加抽烟、酗酒等不健康行为。这些不良行为无疑会对健康产生严重的负面影响，增加患病的风险，降低身体的抵抗力。另一方面，在长期护理保险提供长期护理服务的过程中，往往会伴随着健康宣传以及预防性保健措施。这些举措能够极大地增强人们对自身健康问题的深刻认识，促使他们更加积极主动地采取如体育锻炼和定期体检等有益健康的行为，进而有效提升健康水平。定期体检则可以帮助参保者及时发现潜在的健康问题，采取相应的治疗措施，防患于未然。

（3）储蓄与消费

参与长期护理保险能够显著降低人们在面对失能风险时的不确定性，极大地增强其风险承受能力。这种情况下，参保者可能会削弱预防性储蓄的动机，转而将更多的资金用于当期消费。比如，他们可能会选择购买更优质的食品和保健品，以提升自身的健康状况。优质的食品可以为身体提供充足的营养，增强免疫力；保健品则可以在一定程度上补充身体所需的微量元素，维持身体的正常功能。此外，消费行为的调整还可能包括购买健身器材、参加健康培训课程等，这些都有助于提高人们的健康水平。

（4）心理因素

失能风险的发生及其后果具有高度的不确定性，这很容易引发参保者的“恐惧紧张”心理，导致心理压力的急剧增加。长期护理保险所提供的财务保障能够有力地缓解参保者的财务压力，提高其使用长期护理服务的可及性。这种保障使得参保者在面对失能风险时更加从容自信，从而增强了他们应对风险的信心，减少因担忧失能所引发的焦虑情绪。心理状态的改善对于身体健康至关重要，积极的心理状态可以促进身体的正常代谢，增强免疫系统的功能，进而对健康产生积极影响。

值得特别注意的是，个体初始健康水平的差异会导致不同人群对长期护理保险的需求存在明显不同。健康状况较差的群体极有可能通过长期护理保险的使用

以及健康行为的变化来逐步改善自身的健康状况。而健康状况较好的人则可能更直接地受到经济状况和心理因素的影响。由于他们本身健康状况良好，可能更加关注长期护理保险所带来的经济保障和心理安全感。经济状况的改善可以使他们有更多的资源用于维持健康，如购买高端的健康产品和服务。心理因素方面，长期护理保险提供的安全感可以让他们更加自信地保持健康的生活方式，增强维持或提升健康水平的能力与信心。

本文将基于长期护理保险对健康的影响机理，侧重研究受访者的健康水平因长期护理使用机会的增加而发生的变化，关注受访者健康行为改变后自评健康的变化和心理健况，同时关注长期护理保险的实施对城市死亡率的影响。基于以上分析，本文提出如下假设：发展长护险可以有效提升老年群体的健康水平。

2.1.2 数据来源与模型设定

本实验数据来自北京大学国家发展研究院主持的跨学科调查项目-中国健康与养老追踪调查(China Health and Retirement Longitudinal Study, CHARLS)。该项目旨在收集一套代表中国 45 岁及以上中老年人家庭和个人的高质量微观数据，用以分析我国人口老龄化问题，推动老龄化问题的跨学科研究。CHARLS 全国基线调查于 2011 年开展，覆盖 150 个县级单位，450 个村级单位，约 1 万户家庭中的 1.7 万人。这些样本以后每两到三年追踪一次，调查结束一年后，数据库将对学术界开放。本文对 CHARLS 数据库 2011 年、2013 年、2015 年、2018 年及 2020 年共五期的数据进行合并，得到 80415 个观测值。

在此，我们使用双重差分法研究试点城市对长护险政策的完善能否改善该地区老年人的健康程度，回归模型如下：

$$Health_{ijt} = \beta_0 + \beta_1 Treat_j \times Time_t + \delta \mathbf{X}_{ijt} + \mu_t + \theta_j + \varepsilon_{ijt}$$

其中，下标 i 表示被调查个体，j 表示所在城市，t 表示调查时间；被解释变量$Health_{ijt}$表示被调查个体的健康程度，本文选取调查问卷中的自评健康得分为

代理变量，得分越高代表健康程度越好；核心被解释变量为交互项$Treat_j \times Time_t$，表示该省份是否已经实施完善长护险制度的相关政策；X_{ijt}表示影响个体健康程度的一系列控制变量，详见下表；μ_t为时间固定效应，θ_j为城市固定效应，β_0为常数项，ε_{ijt}为扰动项；系数β_1为双重差分估计量，表示实施完善长护险政策的试点城市对该地区老年人健康程度的影响效果。

表 5 变量名称即构建

变量类型	变量名	变量构建
被解释变量	自评健康得分	很差=1；较差=2；一般=3；较好=4；很好=5
核心解释变量	DID	处理组虚拟变量与政策时间虚拟变量的交互项
控制变量	性别	男=1；女=0
	婚姻状况	已婚=1；其他=0
	户口	城市=1；农村=0
	教育程度	小学以下=1；小学=2；初中=3；高中及以上=4
	家庭规模	家庭总人口数
	子女数量	家庭子女个数

2.1.3 描述性统计

本文对 CHARLS 数据库 2011 年、2013 年、2015 年、2018 年及 2020 年共五期的数据进行合并，并剔除了主要变量有确实和异常值的观测值，得到 80415 个观测值。变量的描述性统计结果见表 1。从自评结果来看，全样本的自评健康得分频数最高为“一般”。与对照组相比，处理组的自评健康水平相对更好，同时也高于总体样本的平均水平。

控制变量中，从人口统计特征看，男女占比分别为 47.3%、52.7%，性别分布较为均衡，有 39.5%的观测值为城市户口，86.5%的受访者婚姻状况为已婚。从教育程度来看，样本中占比最多的为“小学以下教育程度”的受访者（42.64%）。从家庭规模来看，总体样本平均家庭人口 3 人，从子女数量上看，每人约 2-3 个子女。

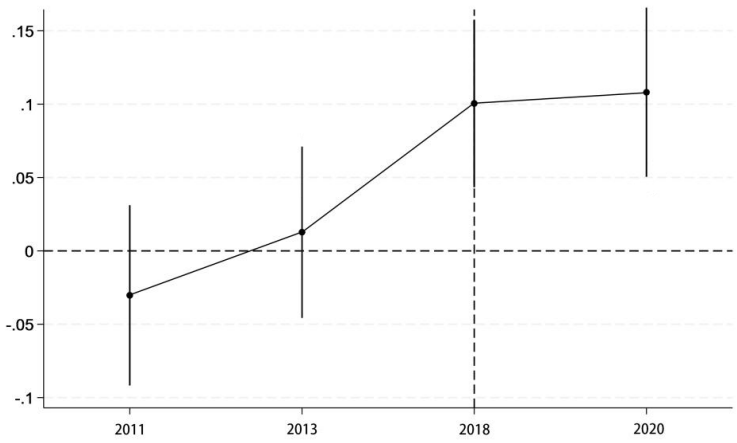
表 6 描述性统计结果

	全样本		控制组		处理组			
变量名	均值	标准误	均值	标准误	均值	标准误	最小值	最大值
DID								
自评健康得分	3.019	0.973	3.016	0．972	3.096	0.976	1	5
性别	0.473	0.499	0.473	0.499	0.470	0.499	0	1
婚姻状况	0.865	0.342	0.865	0.312	0.857	0.350	0	1
户口	0.395	0.489	0.395	0.489	0.401	0.490	0	1
受教育情况	2.010	1.005	2.013	1.048	1.946	1.012	1	4
家庭规模	3.257	1.657	3.274	1.664	2.772	1.381	1	16
子女数量	2.608	1.382	2.619	1.384	2.363	1.290	0	13

2.1.4 平行趋势检验

为检验样本是否具备使用双重差分法的前提，本文先将长护险政策相关城市开始实行的年份作为基准年，将其设为第 1 期，并以此类推；再将实验组个体在政策实施前的各期设为“伪实验组”。由于 CHARLS 数据库中并无政策实施年份即 2016 年的调查数据，因此本文将 2018 年作为实验基期，并将 2015 年数据作为基期的前一期剔除，再进行回归。

图 13 平行趋势检验结果



结果如图所示，其中纵坐标为被解释变量即个体健康程度的估计系数，横坐标为调查年份；实心点表示实验组与对照组的个体健康程度的差异，虚线表示数值所对应的 95%的置信区间。由图可知，2011 年、2013 年两期的个体健康程度

95%的置信区间包含 0 点，表示在实施长护险相关政策前，实验组与对照组的个体健康程度不存在显著差异；在实施长护险相关政策后，估计系数显著远离 0 点且 95%的置信区间远离 0 点，表示相关政策实施后实验组与对照组的个体健康程度出现显著差异出，反映长护险相关政策的实施使个体健康程度更高的概率显著提升。综上，本实验满足平行趋势假设。

2.1.5 基准回归

在验证实验满足平行趋势假设后，本文基于已建立模型探究长护险相关政策对老年人健康程度的影响。表 x 展示了基准回归的结果，其中（1）（3）列未加入控制变量，（2）（4）列加入控制变量；（1）（2）未加入个体固定效应与年份固定效应，（3）（4）列则考虑了双向固定效应以缓解可能存在的遗漏造成的估计结果偏误。回归结果（4）显示，相较于未能实行长护险政策的城市，实行长护险相关政策的试点城市中的老年人健康程度平均提高了 7%，且在 1%的水平上显著。因此，本文认为实行长护险政策能够有效提升所在城市老年人群体的健康水平。

表 7 基准回归结果

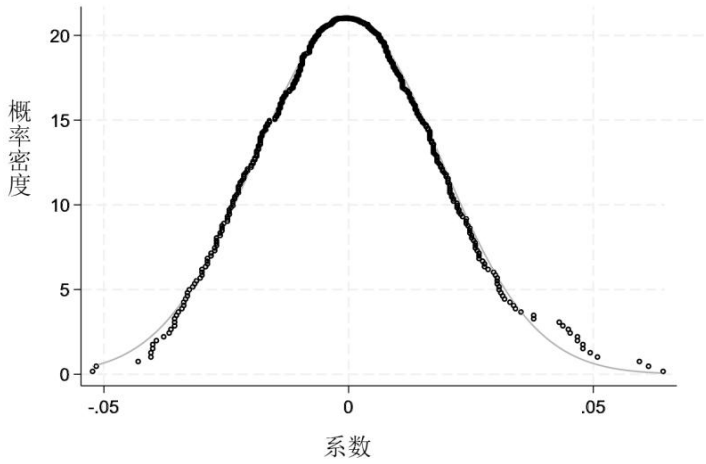
	(1)	(2)	(3)	(4)
变量	自评健康得分	自评健康得分	自评健康得分	自评健康得分
DID	0.080***	0.074***	0.071***	0.072***
	(0.02)	(0.02)	(0.02)	(0.02)
控制变量	No	Yes	No	Yes
个体固定效应	No	No	Yes	Yes
年份固定效应	No	No	Yes	Yes
Observations	80,415	80,415	80,415	80,415
R-squared	0.052	0.028	0.412	0.445

2.1.6 稳健性检验

为验证基准回归结果的可靠性，本文通过实验组随机化的手段进行安慰剂检验。根据长护险相关政策的具体实施情况，本文先将受到长护险政策覆盖的个体

剔除，再从剩余未受到政策覆盖的样本中抽取 10%的样本生成虚拟实验组并进行回归。为避免上述设定的偶然性，本文进行 500 次随机重复抽样，并得到回归结果的系数，结果如图所示。图中横坐标表示长护险实施的估计系数，纵坐标表示随机重复抽样得到的概率密度。由图可知，随机重复抽样的回归系数集中分布在 0 点附近，且显著小于基准回归结果。因此，本文回归中实验组和对照组的个体之间健康程度的差异受到不可观测因素影响的可能性较低，仅仅是长护险相关政策实施的结果，因此本文基准回归结果是稳健的。

图 14 安慰剂检验结果



为进一步确保实证结果的稳健性，缩小测量误差，本文将实验组长护险相关政策实施试点前移至 2013 年，作为虚拟长护险政策的冲击时点，重新进行双重差分检验。结果如表所示，在虚拟政策冲击时点下的 DID 系数并不显著，表示满足政策时间的随机性假设，即前文研究结果稳健。

表 8 政策时点前移回归结果

	(1)
变量	自评健康得分
DID	0.057
	(0.013)
控制变量	Yes
个体固定效应	Yes
年份固定效应	Yes
N	80,415
R^2	0.681

2.2 发展长护险对家庭消费支出水平影响的实证研究

2.2.1 政策背景

我们检验2016年出台的长护险对于家庭人均支出的影响。根据CHARLS数据库的内容，我们针对政策施行前后试点城市家庭人均支出变化率来衡量本次长护险对于家庭平均支出的影响，我们发现，长护险的试行使得家庭人均指出增加6%。其中，我们推测长护险的出台让更多劳动群体不必顾及家中老年人的长期护理支出，进而使得拥有更多用于消费的收入，因此家庭人均支出增加。我们通过回归方法检验了长护险促进消费的机制。

2.2.2 数据选取

本章内容选取 2011-2020 年五期 CHARLS 数据作为基准数据，主要关注年份、是否为试点城市、家庭人均消费水平等数据。我们对家庭人均消费进行了跨期 CPI 平滑，以 2018 年为基期，随后取对数形成我们的解释变量$Smoothln$。

2.2.3 统计结果

表 9 描述性统计结果

变量	观测值	均值	标准差	最小值	最大值
统计波数				1	5
年份	96628			2011	2020
户籍类型	92049			0	1
总收入	59086	37705.88	189481.57	0	39059568
家庭人均消费	72237	14789.10	25128.758	0	1499997.6
家庭规模	96628	3.19	1.627	1	16
子女数量	96628	2.579	1.394	0	15

2.2.4 识别方法

本文采用双重差分法进行识别，以下为基准模型：

$$Smoothln_{it} = \alpha + \mu(treat_c \times post_t) + \lambda X_{it} + \gamma + \varepsilon$$

其中，i，t 分别代表检验城市和时间变量，被解释变量$Smoothln_{it}$是第 i 个个体在第 t 年的家庭人均消费，$treat \times post$是两个虚拟变量的交互项，c 为实施政策的城市，并加上X作为控制变量，γ作为年份和城市的固定效应。

基于对家庭消费的考虑，我们加入了户口、年龄、婚姻、性别、年份等控制变量，并加入了城市、年份固定效应。

我们双重差分的结果如下：

表 10 回归结果

人均家庭消费	回归系数	[95%置信间隔]	
DID	0.063	0.009	0.117
年龄	-0.014	-0.015	-0.013
户籍类型	-0.478	-0.495	-0.460
婚姻状况	-0.069	-0.089	-0.049
性别固定效应	0.027 YES	0.015	0.040

接下来我们进行 t 检验和平行趋势检验用以检查因果关系：

表 11 t 检验结果

Mean dependent var	9.056	SD dependent var	0.953
R-squared	0.162	Number of obs	53335
F-test	1700.757	Prob > F	0.000
Akaike crit. (AIC)	135567.664	Bayesian crit. (BIC)	135629.854

可以看到，经过验证，我们的 T 检验通过。

平行趋势检验中，我们检测出随着政策颁布，回归结果的显著性逐渐提高，但出现略微滞后的现象，可见该政策所带来的福利并非能被迅速感知。

2.2.5 结论

通过双重差分的检验，我们检测出长护险对家庭人均消费带来了约 6%的正向影响。机制为减少中青年在家庭老年人看护上的支出和压力以使得家庭决策中消费的占比增加。然而，我们的实证结果仍有部分不足，如长护险统计指标在 CHARLS 的几次统计过程中并不齐全，无法保证试点地区被调查对象均有长护险支持。但由于可能存在的问题是被统计人数变少，因此我们的相关系数可能被低估，这也进一步验证了长护险在试点城市对于消费段的积极影响。

3 微观聚焦：我国长护险代表体系的模式分析

我国长护险的发展体系主要分为政府保险体系和商业保险体系两大板块。政府保险体系侧重于基础保障，旨在为广大老年人提供必要的长期护理服务；而商业保险体系则更加灵活多样，能够满足不同老年人群体的个性化需求。两者相辅相成，共同构成了中国长护险发展的多元支撑体系。

3.1 地方政府长护险代表体系：以上海市为例

3.1.1 长期布局

（1）明确核心保障项目

《上海市长期护理保险试点办法》的初版（沪府发〔2016〕110 号，已废止）和更新版（沪府发〔2017〕97 号）均详细阐述了长期护理保险的相关规定。该保险主要针对长期失能且需要护理的人士，包括职工医保和居民医保的 60 岁及以上人群，提供日常生活和医疗护理服务的资金支持。

（2）确定资金来源

更新版《上海市长期护理保险试点办法》（沪府发〔2017〕97 号）明确了资金的筹集方式：职工医保参保者按单位缴费基数的 1%从统筹基金中季度性调拨；居民医保参保者则根据 60 岁以上参保人数，以略低于职工医保的标准，从统筹基金中季度性调拨资金。

（3）强化评估和认定流程

在试点阶段，根据《关于全面推进老年照护统一需求评估体系建设意见的通知》（沪府办〔2016〕104 号），完成了包括评估标准完善、信息系统建设、第三方评估机构和评估员队伍建设、评估流程优化等任务，并据此制定了《上海市老年照护统一需求评估标准（试行）》。该标准通过自理能力和疾病严重度两个维度进行评估，将老年人分为八个等级。《上海市老年照护统一需求评估及服务

管理办法》（沪府办规〔2018〕2 号）进一步规范了评估工作，明确了评估的各个方面，包括评估依据、申请条件、部门职责等。《上海市老年照护统一需求评估办理流程和协议管理实施细则（试行）》（沪人社规〔2018〕3 号）进一步完善了具体实施细则。

（4）明确照护服务标准

上述两份《上海市长期护理保险试点办法》文件规定了社区居家照护、养老机构照护和住院医疗护理的服务内容和待遇。服务项目和标准参照《关于印发长期护理保险服务项目清单和相关服务标准、规范（试行）的通知》（沪民福发〔2016〕46 号）中的 42 项服务。参保人员根据评估等级，享受相应时长的服务。

（5）规范资金结算流程

《上海市长期护理保险结算办法（试行）》（沪人社规〔2017〕45 号）规定了长护险的结算流程，包括结算单位、评估费用和三种照护服务的结算。由人力资源社会保障局（市医保办）统一管理，通过评估机构、护理机构和服务提供机构记账，区医保中心审核，市医保中心拨付资金。

（6）与其他政策衔接

《上海市长期护理保险试点办法实施细则（试行）》（沪人社规〔2017〕44 号）将长护险与高龄老人医疗护理计划相衔接，《关于进一步调整本市养老服务补贴政策的通知》（沪民规〔2018〕1 号）为未被长护险覆盖的困难人群和未包含的服务项目提供了保障，确保了养老服务补贴政策与长护险试点政策的衔接。

表 12 上海市长护险政策梳理

时间	政策名称	重点内容
2016.12	《上海市长期护理保险试点办法》（沪府发(2016)110 号）（已废止）	明确长护险定义、适用两类人、市人力资源和社会保障局（市医保办）为主管部门、资金筹集-医保统筹基金、评估等级确立、三种服务形式、建立信息系统
2016.12	关于全面推进老年照护统一需求评估体系建设意见的通知（沪府办(2016)104 号）	确立主要任务，研究制订《老年照护统一需求评估标准（试行）》，明确分级维度和评估结果

2017. 12	《上海市长期护理保险试点办法》（沪府发（2017）97 号）	明确长护险定义、适用两类人、市人力资源和社会保障局（市医保办）为主管部门、资金筹集-医保统筹基金、评估等级确立、三种服务形式、建立信息系统
2018. 1	《上海市老年照护统一需求评估及服务管理办法》（沪府办规（2018）2 号）	评估对象、评估工作的部门职责、评估机构及评估人员管理、评估流程、评估救济渠道、评估费用和服务供给
2016. 12	关于印发长期护理保险服务项目清单和相关服务标准、规范（试行）的通知（沪民福发（2016）46 号）	形成 42 项长期护理保险服务项目清单，制定服务标准和规范
2017. 3	关于本市长期护理保险试点区养老服务补贴政策相关事项的通知（沪民老工发（2017）6 号）（已废止）	试点三区徐汇区、普陀区、金山区长护险与原养老服务补贴的衔接
2017. 12	《上海市长期护理保险试点办法实施细则（试行）》（沪人社规（2017）44 号）	保险年度跟随医保、明确两类人接受社区居家照护和住院医疗护理的待遇
2017. 12	《上海市长期护理保险结算办法（试行）》（沪人社规（2017）45 号）	长护险费用结算管理、结算流程、三种服务形式的结算办法
2018. 1	物价局、卫生和计划生育委员会、医疗保险办公室关于公布本市长期护理保险评估费试行价格的通知（沪价费（2018）1 号）	评估费每次 200 元
2018. 1	关于进一步调整本市养老服务补贴政策的通知（沪民规（2018）1 号）	对长期护理保险试点未覆盖的困难人群和未涵盖的服务项目予以兜底保障，衔接养老服务补贴政策与本市长护险试点政策
2018. 1	《上海市老年照护统一需求评估办理流程和协议管理实施细则（试行）》（沪人社规（2018）3 号）	完善老年照护统一需求评估办理流程、对定点评估机构实施协议管理
2018. 2	关于本市长期护理保险试点有关个人负担费用补贴的通知（沪民规（2018）2 号）	对评估费、护理服务费中需个人承担的部分建立补贴标准

资料来源：深藏 blue 队整理

3.1.2 模式分析

长期护理保险通过社会互助方式筹集资金，为经过评估达到特定护理需求等级的长期失能人员提供基本生活照料及与生活密切相关的医疗护理服务保障的社会保险制度。主要参保人群包括两类：一是参加上海市职工基本医疗保险的人员，二是年满 60 岁的城乡居民基本医疗保险参保者。参加职工医保的人员需按规定申请基本养老金。经过统一的老年照护需求评估，失能程度评估等级达到二

级至六级且在有效期内的人员方可成为参保对象。老年照护统一需求评估是指对符合条件的老年人进行失能程度、疾病状况等的评估，以确定其照护等级，作为享受长期护理保险待遇和养老服务补贴的依据。主要机制如下：

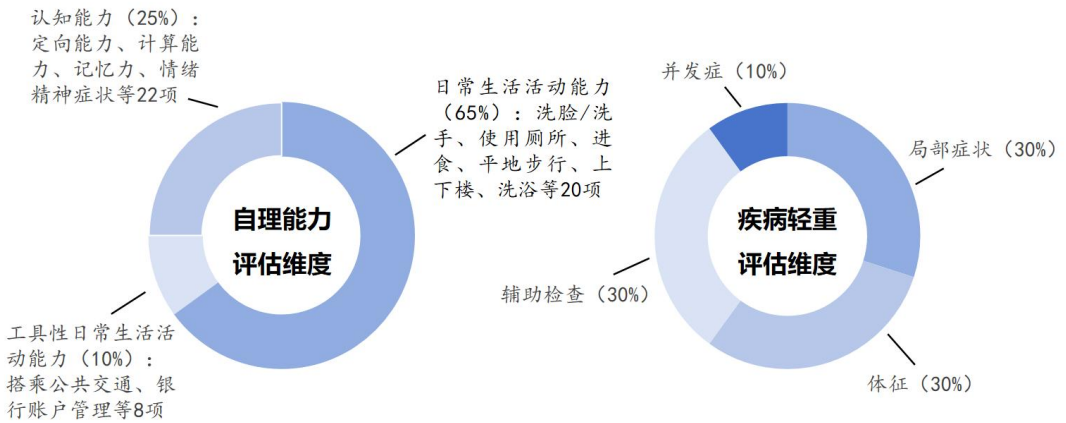
（1）资金筹集

资金筹集主要遵循“以收定支、收支平衡、略有结余”的原则。参加职工医保的人员，其长期护理保险筹资按用人单位职工医保缴费基数的 1%从职工医保统筹基金中按季调剂。对于居民医保人员，资金基于 60 岁以上参保人数，筹资水平略低于职工医保的一类人群，同样按季调剂。长期护理保险的资金来源于医保统筹基金，当前不实行个人缴费。

（2）需求评估

自 2014 年起，上海市已建立一套统一的老年照护需求评估体系。2014 年 12 月，上海市医学科学技术情报研究所受委托负责整合并制定评估方案，成功推出《上海市老年照护统一需求评估调查表》。该工具将老年人分为八个等级，从身体健康、生活自理能力强到照护需求分级，并可建议就医。评估主要关注老年人的身体健康状况，通过自理能力与疾病轻重两个维度进行评定，分别赋予不同权重并计算总分，以确定评估等级。根据评估结果，评估机构可提供服务计划建议，以指导服务机构的具体措施。

图 15 上海市老年照护需求评估体系



资料来源：深藏 blue 队整理

在评估流程方面，老年照护统一需求评估工作由市医保办主管。申请程序由老年人本人或其监护人向就近的社区事务受理服务中心提交书面申请，附带相关材料并选择意向服务机构。经过审核符合条件的，市人力资源社会保障部门将安排指定评估机构进行评估；若不符合要求，则由社区事务受理服务中心通知申请人。指定评估机构在接到评估指令后，将派遣评估人员进行现场评估、记录和出具评估结论，并将结果反馈至社区中心，最终由中心通知申请人确认。

（3）提供服务

通过统一的需求评估，符合条件的申请人需向意向服务机构进行登记确认。在确定服务机构后，该机构将依据申请人的评估等级，结合评估机构提供的服务计划建议，制定相应的服务计划，并告知申请人所享受的长期护理保险待遇及养老服务补贴政策。之后，申请人便可开始接受服务。

（4）给付标准

上海市长期护理保险为老年人提供基本生活照料、医疗护理服务及资金保障，主要包括社区居家照护、养老机构照护和住院医疗护理三种形式。根据规定，60周岁及以上、评估失能程度达到二至六级且在评估有效期内的参保人员，可以享受长期护理保险待遇。社区居家照护的具体待遇如下：若评估等级为二级或三级，每周上门服务 3 次；四级每周 5 次；五级或六级每周 7 次；每次服务时长为 1 小时。对于养老机构照护，评估等级为二至六级的参保人员均可享受相关服务，长期护理保险支付标准为：评估等级二或三级为 20 元/天；四级为 25 元/天；五级或六级为 30 元/天。

（5）费用结算

老年照护统一需求评估的收费标准为每次 200 元。社区居家照护的收费标准如下：执业护士提供照护服务的费用为 80 元/小时；医疗照护员为 65 元/小时；养老护理员和健康照护员等则为 40 元/小时。社区居家照护服务费用由长期护理保险基金支付 90%。对于养老机构照护，收费标准为：评估等级二或三级为 20 元/天；四级为 25 元/天；五级或六级为 30 元/天。若实际服务费用低于上述标准，

则按实际费用计算。长期护理保险费用在养老机构的支付依据为实际入院天数，由基金支付 85%。

3.1.3 存在问题

当前，上海市的社会长期护理保险制度在实施过程中显现出诸多问题，主要源于制度设计的缺陷以及缺乏有效的实施环境。

（1）制度设计存在不足

尽管上海市面临大量低保与低收入人员，2017 年的城乡低保标准虽已提升至每月 970 元，低收入人员标准也设定为低保标准的两倍，即 1940 元，然而，2016 年约有 20 万城乡低保人员。在老年群体中，依据《上海市老年人口和老龄事业监测统计调查制度》，约有 423 万 60 岁及以上的老年人在领取基本养老金，这使得大约 35 万老年人没有任何养老金。在当前制度中，个人承担居家与机构长期护理服务费用分别为 10%及 15%，但其设计并未顾及经济困难人群，导致这部分人难以承担相关费用。

（2）未能建立统一的管理信息系统

虽然上海市对各相关部门的职责进行了明确分配，人口资源和社会保障部门负责政策制定与基金管理，卫生和计划生育委员会负责失能评估及医疗护理，而民政部门则负责生活照料服务。但由于尚未形成统一的管理信息系统，导致各部门无法高效协作，实施效率低下，甚至可能出现重复评估的情况。例如，在制定老年人的长期生活照料服务计划时，民政部门仅能获得评估等级，无法了解老人的详细身体状况，往往需要重新进行评估。管理信息系统的不统一是当前实施中面临的主要障碍。

（3）服务提供存在明显局限

尽管上海市社会长期护理保险制度中规定了 27 项生活照料服务和 15 项医疗护理，涵盖了老年护理服务的多个方面，仍暴露出一些问题。一方面，医疗护理服务人员数量及质量存在明显不足，主要提供的还是家政服务，无法满足老年人

的医疗需求；另一方面，生活照料服务中的许多项目如洗澡等，受传统文化影响，老年人可能不愿意配合或接受，且真正需要的生活服务项目在目录中并未列入。这些问题导致了服务供需之间的不匹配。

3.2 商业养老服务体系下的寿险业务：以中国平安为例

3.2.1 公司介绍

（1）发展历程

中国平安是国内金融牌照最齐全、业务范围最广泛、控股关系最紧密的综合金融集团之一。1988 年平安于深圳蛇口成立，成为我国第一家股份制保险公司。1994 年公司启动寿险业务，在中国内地首开个人寿险营销模式。2003 年中国平安保险集团正式成立，并于 2004 年、2007 年成功在 H 股和 A 股完成 IPO。2011 年平安合并原平安银行，建立全国性银行业务布局。2017 年公司市值突破万亿人民币，位居全球保险集团第一。截至目前，中国平安总资产超过 11 万亿元，为近 2.27 亿个人客户和超 6.93 亿互联网用户提供多样化产品及便捷服务。

图 16 中国平安发展历程



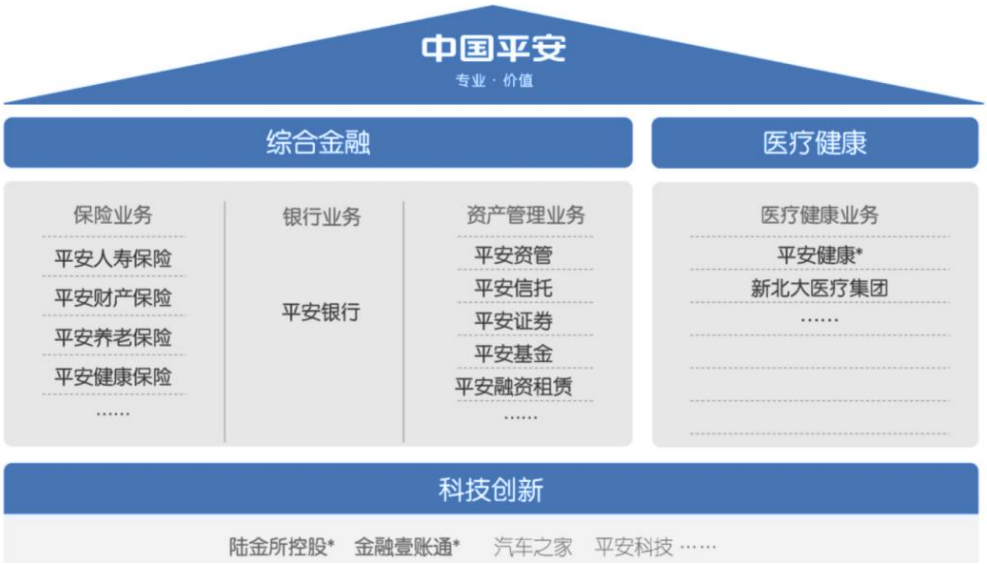
资料来源：公司官网，深藏 blue 队整理

（2）业态分布

平安集团旗下专业公司包括以保险、银行、资管为代表的综合金融业务和以

平安健康、北大国际医院为代表的医疗健康业务，涵盖金融、医疗的各个领域，已发展成为中国少数能为客户同时提供全方位金融和医疗健康产品和服务的企业之一。子公司平安寿险、平安养老险和平安健康险，是公司寿险及健康险业务板块的主要经营主体：平安自 1994 年启动寿险业务，目前平安寿险是中国第二大寿险公司；平安养老险和平安健康险分别成立于 2004 年和 2005 年，是国内首家专业养老险公司、国内首批设立的专业健康保险公司。

图 17 中国平安业态分布



资料来源：公司官网，深藏 blue 队整理

3.2.2 业务模式

（1）给付条件

“长期护理保险金”要求合同“特定疾病释义”定义的“疾病或疾病状态”导致日常生活能力障碍、引发护理需要且达到本附加险合同约定的护理状态，同时自满足本附加险约定的护理状态之日起持续 180 日后仍符合本附加险合同约定的护理状态；“意外长期护理保险金”要求被保险人在 70 周岁的保单周年日前因意外伤害导致日常生活能力障碍、引发护理需要且达到本附加险合同约定的护理状态，则自满足本附加险约定的护理状态之日起，被保险人该护理状态持续 180 日后仍符合本附加险合同约定的护理状态。

（2）评估标准

护理状态的要求：（1）失能；（2）严重认知障碍；鉴定要求：经二级以上（含二级）公立医院的专科医生诊断或司法鉴定机构鉴定并出具证明。

3.2.3 SWOT 分析

（1）优势（Strengths）

（a）依托“管理式医疗”健康生态，提供差异化健康管理服务

中国平安创新推出中国版“管理式医疗模式”，将差异化的医疗健康服务与作为支付方的金融业务无缝结合，为个人及团体客户提供一站式医疗健康服务，赋能金融主业。截至 2023 年 3 月末，在平安近 2.29 亿个人客户中，有超 64%的客户同时使用了医疗健康生态圈提供的服务。

图 18 中国平安“管理式医疗”健康生态平台



资料来源：公司官网，深藏 blue 队整理

“保险+健康管理”方面，平安提出“1 个专业医生”+“4 大服务内容（健康管理、亚健康管理、疾病管理和慢病管理）”和“10 大管理手段”的“1+4+10”服务体系。公司于 2021 年推出“平安臻享 RUN”健康服务计划，为客户提供全生命周期的医疗健康服务，重点打造“特色体检、在线问诊、门诊预约协助及陪诊、控糖管理和重疾专案管理”五大亮点服务。“平安臻享 RUN”分为乐享、尊享和尊享 PLUS 三档计划，分别针对大众、中产和富裕客群，提供差异化的服务体验。2022 年

平安寿险已累计服务约 1859 万客户，获得客户广泛认可。

图 19 “平安臻享 RUN”平台



资料来源：公司官网，深藏 blue 队整理

（b）发力高端养老与居家养老领域，满足客户养老需求

“保险+高端养老”方面，平安致力于开拓高品质养老服务市场，创新构建覆盖长者全生命周期的“一站式”养老解决方案，为长者提供定制专享的康养服务，以满足中国高品质养老领域日益增长的需求。2021 年 5 月，中国平安发布“平安臻颐年”康养品牌及首个高端产品线“颐年城”。2022 年 10 月，伴随新产品线“逸享城”正式对外发布，平安臻颐年开启双产品线布局。

图 20 平安高端养老服务体系发展历程



资料来源：平安臻颐年官网，深藏 blue 队整理

“颐年城”产品线作为平安臻颐年城市型高品质持续照料康养社区，优先聚焦一线城市及部分二线城市的核心区位项目，已在全国逐渐布局。2023 年 2 月，伴随着上海颐年城正式对外发布，该产品线已覆盖深圳、广州、上海三个城市，杭州、北京等城市项目也即将加速来临。“逸享城”产品线作为全新臻选型城市旗舰康养社区，致力于布局全国新一线城市。2022 年 10 月，佛山逸享城正式亮相，初步完成大湾区业务布局。未来，将会在苏州、武汉等更多新一线城市持续布局。平安臻颐年的最大优势在于核心区位选择。

平安臻颐年引领行业高品质康养标准的“五臻”标准服务体系，包含五大亮点：核心区位、稀缺医疗与资源优享、终生管家、精微照护及品质尊享。我们认为，不同于其他同类养老社区或因综合考虑成本等因素将社区定位于郊区，平安臻颐年专注于核心区位的核心地段，周边商圈、交通与医疗一应俱全，致力于打造高品质康养服务，以满足长者的多元生活需求。

表 13 平安臻颐年产品亮点分析

亮点	概述
核心区位	布局北上广深等核心城市核心区位，环抱多元生活圈，荟萃丰富的商圈资源，交通便捷，生活配套完善，毗邻三甲医院。
稀缺医疗+资源优享	**“1%稀缺”顶级资源** 1)专医：专业医生，三甲医院主任医师级别以上，24 小时线上全天侯服务 2)专科：全国各区域排名前 10 专科，线下 1 天内，线上最快 1 小时完成预约 3)专院：提供龙华医院、北大国际医院等专属三甲医院及多个康复医院医疗资源 4)专案：全球排名前 10 机构，制定整合式专业医疗方案
	“100%定制”健康服务 1)康养服务完美贴合日程：私人秘书对接，精准规划时间，健康管理、医疗计划贴合商务日程 2)全面定制健康管理计划：以细致做定制，超 100 项健康指标全面评估，高发疾病早干预、早发现、早治疗
终生管家	配备 1×N 专属管家团，定制个性化全场景生活服务，1 位专属管家周到服务，N 位行业专家提供支持，金融、健康、生活， 一站式贴心守护。
精微照护	采用国际康复照护领域 CARF 标准作为衡量标尺，携手卓越国际养老服务商倍乐生集团，引进日式照护标准，打造一流的服务体验。
品质尊享	加入臻颐年俱乐部，会晤 TOP 级私密图层；国际知名疗养机构，提供稀缺入住席位，预留专属服务周；百余项私密禅修及冥想课程，专职记者采访。

资料来源：公司官网，深藏 blue 队整理

（c）提升会员保费门槛，形成高品质服务良性循环

平安臻颐年客户通过康养社区入住权益和保单相结合的方式，投保平安臻颐年体系产品，即可享受按照“臻标准”服务体系打造的优质康养生活体验。根据平安人寿官网智能客服，平安臻颐年对接产品包括颐享延年养老年金、金瑞人生（2021）年金险等产品。从入住保费门槛来看，平安臻颐年产品目前处于第三期销售，最低保费门槛为康养一期的 1000 万元，显著高于同业。在现行的康养三期销售期内，可获“颐年城”入住权益的臻享会员 V1/V2/V3，保费最低门槛分别为 1888 万、3288 万及 4388 万，可获“逸享城”入住权益的逸享会员的保费最低门槛为 588 万。保费门槛远远高于同业。

表 14 平安臻颐年各期保费门槛

	康养一期	康养二期	康养三期
销售期	2021.1.1-2021.7.16	2021.9.15-2022.11.30	2022.12.1-2023.11.30
臻享会员 V1	新单总保费≥500 万且新老单总保费≥1000 万	新单总保费≥1000 万且新单 FYP≥200 万且新老单总保费≥1888 万	
臻享会员 V2	新单总保费>500 万且新老单总保费≥2000 万	新单总保费≥1000 万且新单 FYP>200 万且新老单总保费>3288 万	
臻享会员 V3	新单总保费>500 万且新老单总保费≥3000 万	新单总保费≥1000 万且新单 FYP>200 万且新老单总保费≥4388 万	
逸享会员			新单总保费>500 万且新老单总保费>588 万

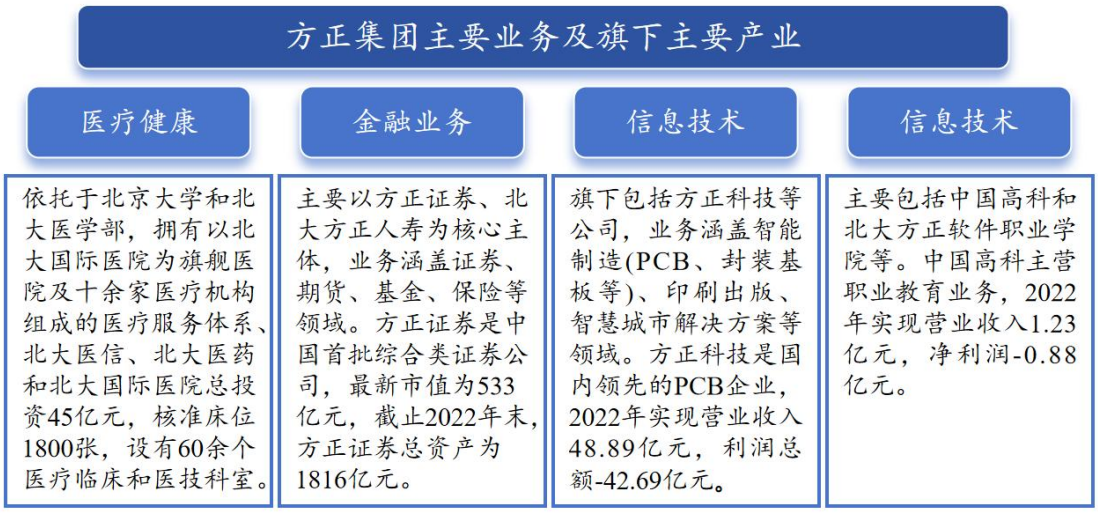
资料来源：公司官网，深藏 blue 队整理

平安养老居家体系挂钩“1+N”产品组合，为购买者提供多种产品组合的选择。根据平安人寿官网智能客服，其中“1”指的是需在“居家产品清单”中的必选产品，包括颐享世家、盛世金越尊享等系列共计 20 余种寿险产品；“N”指的是“居家产品清单”中的非必选产品。对接平安养老居家权益的保费共分为 V1/V2/V3 三档，保费最低门槛分别为 100 万、300 万及 500 万，其中必选产品至少达到 40/120/200 万。目前，在居家养老有所涉及的险企中，最低保费门槛大多集中在 30-50 万左右，根据加倍保 Max 微信公众号，阳光人寿“孝无忧”和爱心人寿均为 30 万，友邦人寿的“友自在”为 50 万元，平安的居家养老服务权益以最低保费门槛水平 100 万远超同业。

（d）参与方正集团重整，增厚医疗健康领域资源实力

中国平安参与方正集团重整，已正式成为控股股东。2021 年 4 月平安集团授权平安人寿作为投资主体，以“出售式重整、整体承接”的方式与华发集团按 7:3 的比例承接剩余不低于 73%新方正集团股权。2022 年 1 月底获银保监会批准，拟出资 482 亿元受让新方正集团约 66.51%的股权；2022 年 12 月新方正集团完成相应企业变更登记手续，平安人寿正式控股新方正集团。

图 21 方正集团主要业务及旗下主要产业



资料来源：公司官网，海通证券研究所，深藏 blue 队整理

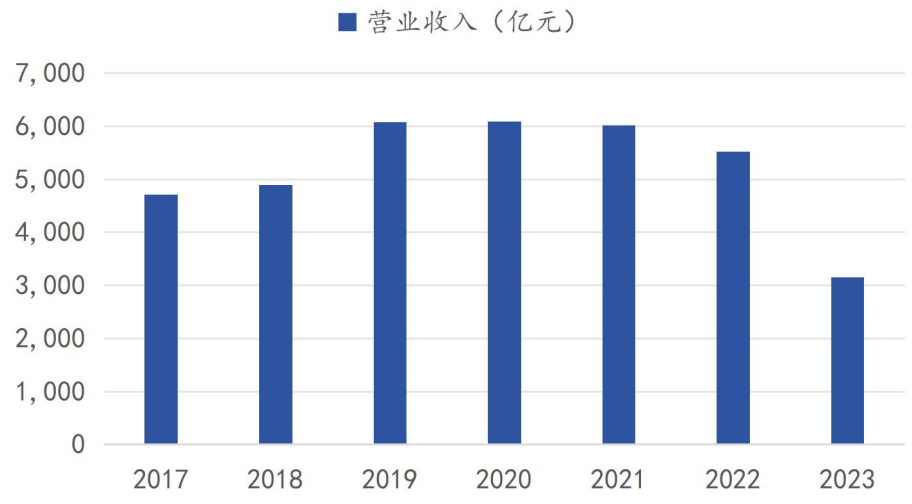
中国平安参与方正集团重整投资是双赢的合作。对中国平安而言，可进一步深化医疗健康产业战略布局，加快构建医疗健康生态圈，打造价值增长新引擎。通过覆盖各地区的医院，与保险业务形成协同，致力打造有场景、有服务、有温度、有频率的医疗健康生态圈，并建设国际一流医院，打造领先的知名医疗集团，助力线下医疗及保险业务获客。同时利用科技赋能医疗生态圈，既结合线上平台，完善扩充自建医生团队，也借助医院信息管理系统，发展智慧医疗，推动传统医院转型；对方正集团而言，平安集团在重组和特殊资产投资领域的经验，可促使其化解债务危机、回归健康可持续发展轨道。

（2）劣势（Weaknesses）

（a）新业务增速放缓

2023 年中国平安寿险及健康险业务新业务价值虽然同比提升 11%，但用来计算新业务价值的首年保费同比下滑 19%，新业务合同服务边际也同比下滑 12.6%，新业务利润率同比下降 0.2%，中国平安新业务盈利能力存在下降的可能，未来可能会影响整体业绩表现。

图 22 中国平安寿险业务营收趋势



资料来源：公司年报，深藏 blue 队整理

（b）筹资渠道过于单一

平安人寿在长护险的筹资上过度依赖医保基金，这限制了资金来源的多样性，增加了财务风险。在长期及动态角度来看，随着社会平均失能周期的延长，长护险后期给付压力将持续扩张，单一的筹资渠道可能无法实现成本的全覆盖和满足覆盖群体的参保需求。

（c）销售渠道高度依赖代理人

虽然代理人渠道是平安人寿的主要销售渠道，但过度依赖单一销售渠道可能会限制长护险产品的市场渗透率。报告显示，2024 年前三季度，平安寿险及健康险业务实现新业务价值 351.6 亿元，同比增长 34.1%，其中代理人渠道新业务价值同比增长 31.6%。这种依赖代理人销售的模式可能会在市场环境变化时面临挑战。

（3）机会（Opportunities）

（a）市场潜力空间大

随着人口老龄化的日益加剧，我国失能失智老年人规模越来越庞大。2015 年，第四次中国城乡老年人生活状况抽样调查显示，全国失能、半失能老年人约 4063 万人，占老年人口的 8.3%。全国老龄工作委员会预测，2030 年和 2050 年失能老人规模将分别达到 6168 万人和 9750 万人，意味着长期护理服务需求激增。同时，各项研究表明，我国传统家庭护理功能正在不断弱化。老年人家庭护理依赖于配偶的生存状况和子女居住地理位置的邻近。在过去的几十年里，越来越多的老年人因为离婚、丧偶而独自生活。而长期实行的独生子女政策导致家庭结构小型化，加大了失能老人的护理压力。此外，女性劳动参与率的提高、家庭价值观念的转变，也减弱了家庭护理功能。因此，老年人长期护理服务必将由家庭转向第三方机构，护理费用也将不断攀升。有研究预测，2050 年我国人均长期护理费用为 60795 元。护理费用的增加，会提高老年人对商业长护险的参保积极性。

（b）政策支持力度高

我国政府对老龄化的重视程度以及对社会各方共同解决老龄化带来的挑战和机遇的支持力度很大。经由十九大和“十四五”规划，老龄化相关问题已经上升到一个前所未有的重视程度。2016 年，人社部发布《关于开展长期护理保险制度试点的指导意见》，标志着我国政策性长护险正式试点落地。同时，中国银行保险监督机构也在考虑如何助力保险行业共同把商业护理保险发展得更好更快，相信未来会有更多的支持措施陆续出台。

（c）保险公司积极性高

综合来看，长期护理保险是新业务价值率比较高的业务类型。我国的保险公司，尤其是寿险公司对新业务价值的追求还是比较高。根据测算，比如以疾病失能状态为给付条件的护理型产品，在考虑到恶化因子、久期和资本占用等因素的情况下，仍是新业务价值率比较高的业务类型。另外，长期护理保险是一个资本金友善型产品，符合保险公司的经营需要。综合考虑以上两点因素，保险公司会有意愿和动力去推动此类产品。

（d）保险科技平台发达

近年来，百万医疗、普惠型城市医疗产品等现象级保险产品蓬勃兴起，这与保险科技平台在年轻人群中的广泛普及息息相关。据了解，以 i 云保为例，截至目前该平台已凭借其科技优势，累积为超 300 万家庭提供了保障服务. 而长期护理保险领域，若能引入普惠制模式并介入保险科技平台，或可借助平台的大数据分析、智能匹配等功能，精准对接需求，降低成本，提高服务效率，从而发挥较大优势，为更多人提供更优质、更普惠的保障。

（4）威胁（Threats）

（a）市场竞争加剧

随着越来越多的保险公司进入长护险市场，相关市场竞争将变得更加激烈。当前进入长护险赛道中的保险公司除平安人寿以外，中国人寿、中国人保、中国太保、新华保险、友邦保险等，各公司分别在众多城市建立养老社区，其中不乏存在部分城市重复建设，供大于求的情况出现，长期来看可能会加剧行业竞争激烈程度，降低各保险公司的盈利空间。

表 15 长护险市场中养老社区网点规划

保险公司	养老社区	网点规划	最低入住保费门槛
泰康人寿	泰康之家	北京、上海、广州、三亚、苏州、成都、武汉、杭州、南昌、厦门、沈阳、长沙、南宁、宁波、合肥、深圳、重庆、南京、郑州、青岛、福州、温州、天津、济南、内蒙古	200 万
人保寿险	人家颐园	大连	200 万
中国人寿	国寿嘉园	北京、天津、苏州、三亚、深圳	200 万
太平人寿	梧桐人家	北京、上海、合肥、青岛、三亚、苏州、杭州、广州、昆明	120/150 万起
太保寿险	太保家园	成都、武汉、上海、大理、南京、厦门、杭州	200 万
新华人寿	新华家园	北京、海南博鳌	200 万
阳光人寿	阳光人家	广州、上海、廊坊	100 万

资料来源：海通证券研究所，深藏 blue 队整理

（b）长护险基础设施不完善

如果和重疾保险、医疗保险相比，大力发展商业护理保险类业务的“基础设施”目前尚不完善。由于护理保险还是一个小众产品，缺乏影响力，还未形成一系列统一的行业定义与赔付标准，仍处于市场培育的过程中。因此，还存在缺乏统一权威的失能鉴定机构鉴定标准，统一的护理服务标准和机构，长期护理服务供给不足，养老产业链联动不足等问题。如果下一步要把护理保险作为行业发展的重点，这些问题都需要有关部门解决。

（c）消费者潜在护理认知不足

当前，消费者缺乏将护理保险需求当作目前需要的主要保险的意识，这一点和国外消费者的保险意识是相同的。同时，消费者很多时候把护理保险与医疗保险、健康保险、甚至养老金保险相混淆，理解偏差较大。另外一方面，很多消费者对护理保险存在的顾虑或者需求不一样，他们对现金补偿顾虑较小，但当自己需要护理服务的时候，对可获得的服务疑虑更多：即是否能有相对可靠的护理机构和护理人员提供服务。如果产品提供的是纯粹的经济补偿，护理保险在中国还缺乏足够的吸引力。

4 政策建议：加快完善长护险体系建设

2016 年以来，经过八年探索，中国长期护理保险从零开始起步，其社会影响力越来越大，逐渐被广泛认可，为失能老年人又建立起一道风险屏障，使“机构不能医、医院不能养、家庭无力护”的困局在一定程度上得到了解决，成为应对人口老龄化和社会保障体系建设中的一项重要制度。

根据国家医保局发布《2023 年全国医疗保障事业发展统计公报》，截至 2023 年末，49 个试点城市参加长期护理保险人数共 18330.87 万人，享受待遇人数 134.29 万人。2023 年基金收入 243.63 亿元，基金支出 118.56 亿元。长期护理保险定点服务机构 8080 家，护理服务人员 30.28 万人。

各试点城市深入探索建立适应我国国情的长期护理保险制度，在许多政策领域进行了有益探索，取得初步成效，但也存在一些问题。基于前文的研究结论，本模块将对我国长期护理保险制度的完善提出建议。

4.1 享受待遇的目标人群的确定

4.1.1 参保对象覆盖：以城镇职工为主还是扩展至城乡居民？

长期护理保险基金在来源上主要是医保基金的“平移”，这就导致长期护理保险参保人实际上与医疗保险参保群体重合。然而，在各试点城市中，长期护理保险的覆盖范围呈现出较大的差异性。在当前的 49 个试点城市里，长期护理保险覆盖范围主要可归纳为两种模式。其中，“模式一”表现为仅针对职工医保参保人群，这种模式在部分城市中实施，其重点关注了职工群体的长期护理需求保障情况；“模式二”则是将覆盖范围拓展至职工医保和城乡居民医保参保人群，这种模式考虑到了更广泛的社会群体，包括城市居民和乡村居民，使长期护理保险的保障范围更为宽泛。

总体来看，在过去几年里，2016 年第 1 批试点城市的发展趋势是从模式一扩展至模式二，长护险参保人群范围不断拓宽。例如，在第一批 35 个试点城市中，

最初有 14 个城市采取模式一，2019 年以后，有 7 个试点城市先后从模式一转向模式二。相比而言，2021 年第二批 14 个试点城市在确定参保范围时显得十分谨慎，考虑到制度支出压力和服务触达能力，仅有 4 个城市采取模式二。

表 16 长期护理保险试点城市参保对象情况

模式	参保对象	试点地区	合计
模式一	城镇职工医保参保人	承德、齐齐哈尔、安庆、重庆、潍坊、临沂、聊城、天津、晋城、盘锦、福州、湘潭、南宁、黔西南州、昆明、汉中、甘南州	17
模式二	城镇职工医保+城乡居民医保的参保人	长春、青岛、上海、苏州、南通、宁波、上饶、荆门、广州、成都、石河子、吉林、松原、通化、梅河口、珲春、济南、淄博、枣庄、东营、烟台、济宁、泰安、威海、日照、德州、滨州、菏泽、乌鲁木齐、北京石景山区、呼和浩特、开封	32

资料来源：深藏 blue 队整理

在模式一向模式二延伸的过程中存在一个倾向，即随着长期护理保险实现全民参保之后，制度收入快速增长，但服务项目的覆盖范围却未随之相应得到延伸，导致基金结余规模与日俱增。例如，上海市 2016 年参保范围仅覆盖职工医保参保人群，2019 年延伸至居民医保参保人群，参保人数从 37 万人迅速扩大到 659 万人，基金收入也快速提高。但年均基金支出仅为年均收入的 25%，截至 2023 年底，形成累计基金余额高达 20 亿元，相当于可支付 16 年的基金规模，资金使用处于严重低效状态。

在未来推进建立长期护理保险制度的进程中，对制度覆盖范围的拓展应提出技术和参数要求，设定 2035 年之前为过渡期，在过渡期内，长期护理保险服务项目如果难以“触达”和“下沉”至农村偏远山区，应先夯实城镇职工医保人群的长期护理保险服务项目。以此为基础，允许按不同服务项目，先易后难，逐渐向农村尤其农村偏远山区延伸，随着支出的提高，逐渐提高缴费比例和基金收入规模，不断积累经验，防止揠苗助长，提高资金使用效率，以减少全社会的福利损失，待 2035 年过渡期完成之后再要求实现全民覆盖。

4.1.2 保障对象覆盖：窄口径模式与宽口径模式？

在窄口径保障模式下，长期护理保险基本只覆盖重度失能人员。以承德、长春、吉林为代表的 26 个试点城市长护险政策强调，长护险保障对象限制为“因年老、疾病、伤残等导致失能，经过医疗机构或康复机构规范诊疗，失能状态持续 6 个月以上生活不能自理，病情基本稳定且通过失能评定的**重度**失能人员”。

相对而言，中口径保障模式更强调“优先保障重度失能人员，其他人员亦有覆盖”，如齐齐哈尔、荆门等 10 个试点城市所规定。

值得关注的是，部分试点地区扩大了保障范围，采取宽口径保障模式：（1）如成都、上饶和青岛，将失智人员纳入保障。（2）如上海制度建设相对比较完整，不仅对重度失能人员有保障，“中度失能”也能享受到应有的福利。

表 17 长护险保障对象覆盖模式情况

保障对象覆盖模式	代表城市	特点
窄口径	承德、长春、吉林等	条件严格，基本只覆盖重度失能人员，且对失能时间有持续 6 个月以上的要求
中口径	齐齐哈尔、荆门等	优先保障重度失能人员，其他人员亦有覆盖
宽口径	成都、上饶、青岛、上海等	覆盖范围更广，条件更灵活，例如将“中度失能”人员，以及失智人员纳入保障范围内

资料来源：深藏 blue 队整理

据学者程明梅、杨华磊（2024）估算与预测，到 2035 年，城镇重度失能人数将净增 264 万人，全国 65 岁及以上的重度失能老年人总数预计将达 1574 万人。在这项研究中，作者估算 2021 年 65 岁及以上的全国失能老年人数为 2355 万人，但与实际现实结果进行比对后发现（全国 60 岁及以上失能、半失能老年人 4063 万，失能率为 18.3%），这项学术研究的估算结果已经非常保守了。这说明，长期护理保险即使采取窄口径保障模式，未来的压力也是非常大的。

为此，建议在 2035 年之前的过渡期内，对保障模式的扩展采取谨慎态度。对新建立的长期护理保险制度的保障模式应作出明确规定，窄口径保障模式应成为主流保障模式。2035 年之后，随着个人缴费能力提高，尤其是在财政投入提高之后，筹资水平逐渐提高，长期护理保险保障模式的扩展问题再提到议事日程。

4.2 服务侧重：以基本生活照料为主与以医疗护理为主？

当下整体来看，49 个长护险试点城市提供的服务内容主要包括清洁照料、饮食照料、排泄照料、卧位与安全照料等居家日常生活护理以及与之密切相关的机构医疗护理两大类。

以扬州市为例，其居家上门照护服务项目分为安养照护、康养照护以及医养照护，打造出了多样化和特色化的服务类别，能够满足不同老年群体的居家护理需求。

表 18 扬州市长期护理保险居家上门照护服务项目与内容

服务类别	服务人群	服务项目	服务频次
安养照护	仅需生活照料的重度失能人员	头面部清洁及梳理、口腔护理、洗发、手/足清洁、指/趾甲护理、助浴、协助进食、大便失禁护理、尿失禁护理、整理床单、压疮预防	12 次/月
康养照护	有特殊照护需求的重度失能人员	助浴、便秘管理、大便失禁护理、尿失禁护理、整理床单、压疮预防、安全护理、协助移动、便袋照护、协助排痰、鼻饲、康复（关节活动）	10 次/月
医养照护	有指定医疗护理需求的重度失能人员	便秘管理、大便失禁护理、尿失禁护理、压疮预防、给药、留置胃管、压疮护理、灌肠、导尿、造口护理、康复（步行训练）、康复（平衡训练）	6 次/月

资料来源：深藏 blue 队整理

但实际上，在长期护理保险制度中，生活照料与医疗护理两类项目之间也存在交叉与界限不清的地方，如无量化规定，“与基本生活密切相关的医疗护理”将很难定义，甚至产生争议。而长护险与基本医保两个制度的支付边界本身就存在模糊不清的灰色地带，加之长护险“搭载”于医保制度之上，如不处理好生活照料与医疗护理二者的关系，长期护理保险容易走向医疗服务“养老化”或养老服务“医疗化”的极端，而这两种倾向均不是完整意义上的“康养融合”。

本文认为，首先建议制定长期护理保险服务项目与器械（报销）目录，此目录与国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录并列，以廓清支付界限；再次，建议尽快建立长期护理保险的生活照料、医疗护理和辅助器具的《待遇清单制度》，如同 2021 年公布的《医疗保障待遇清单制度》，通过国家层面统一

待遇清单，对服务项目和质量标准加以规范，为建立其价格形成机制和支付机制创造条件；最后，对生活照料与医疗护理在基金支出比例或项目数量比例上作出明确规定。

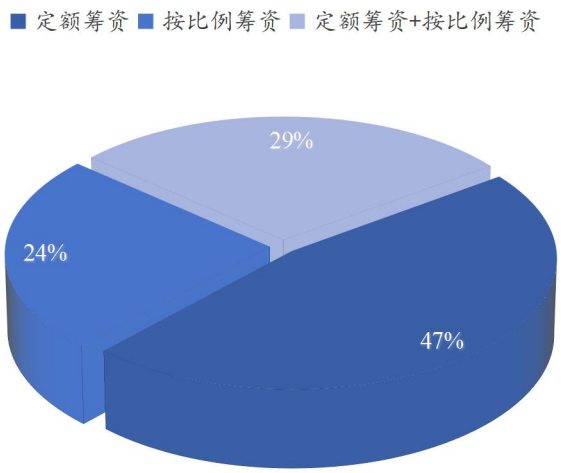
4.3 筹资模式选择

远期看，长期护理保险在社会保障体系中应是一个独立险种，这既是 80 号文和 37 号文确定的一个制度目标，也是确保医疗保险和长期护理保险两个制度在财务上得以健康运行的制度保障，而建立一个独立的筹资模式则是建立独立险种的首要条件。鉴于目前长护险筹资模式的碎片化现象，若要从国家层面总体统筹规划，就涉及要设定一个合理的筹资水平区间，确定一个具有可负担性和可持续性的筹资渠道，建立一个长期稳定且与风险水平相匹配的费率结构。

4.3.1 筹资水平

各试点城市筹资方式不同，可分为定额筹资、按比例筹资、定额筹资+按比例筹资三种。

图 23 试点城市筹资方式

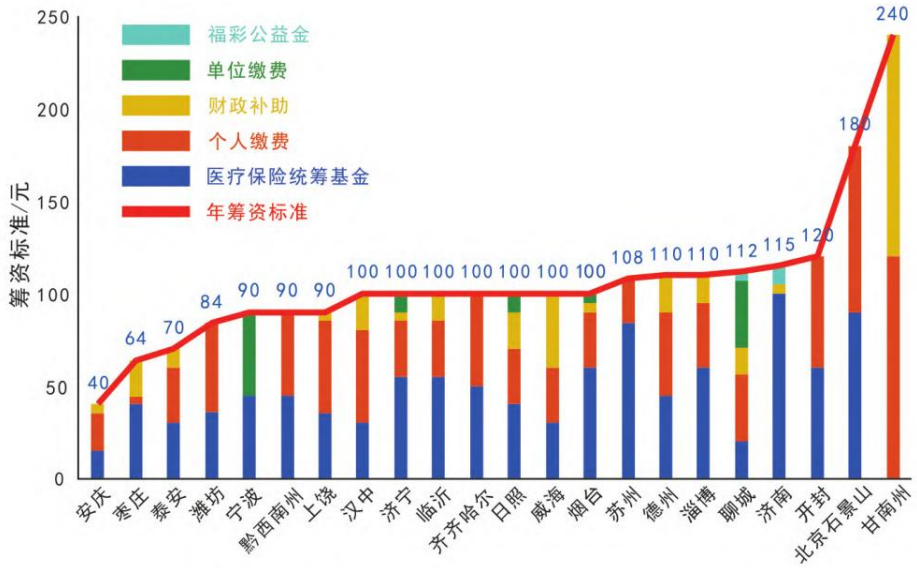


资料来源：深藏 blue 队整理

定额筹资是指以固定金额进行缴费，23 个试点城市采取该方式筹资，不同试点城市定额筹资标准存在较大差异。例如，城镇职工基本医疗保险参保人的长护险筹资标准为 40 元~240 元/年。从城镇职工长护险筹资渠道来看，医疗保险、个人缴费及财政补助 3 种渠道承担了较高的筹资比例，医疗保险统筹基金承担了 17%~87%，个人缴费承担了 6%~57%，财政补助承担了 5%~40%。

图 4 定额筹资试点城市城镇职工长护险年筹资标准及渠道

图 24 定额筹资试点城市城镇职工长护险年筹资标准及渠道



资料来源：深藏 blue 队整理

按比例筹资是指以某一数值（如医保缴费基数）为基数，按一定比例筹资，共有 12 个城市通过该方式筹资；定额筹资+按比例筹资即城镇间城乡居民长护险筹资标准差异较大，筹资标准为 12 元~180 元/年，最高的为北京石景山，最低的为吉林省 6 个试点城市。

由于不同城市筹资水平差异较大，本文建议，全国应统一采用按比例筹资的形式，确定长护险缴费率为 0.25%左右（以医保缴费基数为基数）。在可获得数据的 2021 年 44 个试点城市中，其职工群体人均筹资标准为 123 元/年，其中，有 17 个城市人均筹资标准低于 90 元/年，有 21 个在 90 元/年至 200 元/年之间，其余的高于 200 元/年。由此看来，123 元/年可作为统一筹资水平的一个主要参

考值，而 123 元/年大致相当于全口径社会平均工资的 0.15%。考虑到医保缴费基数在大多数城市是实际工资的 60%左右，城镇职工的长期护理保险筹资水平可确定为医保缴费基数的 0.25%左右。

4.3.2 筹资渠道

当前，49 个长护险试点城市均基于医保基金进行多元化筹资，虽然在 2020 年 37 号文提出筹资以单位和个人缴费为主且原则上按同比例分担，但时至今日绝大多数试点城市的筹资结构并不平衡。来自医保基金划出的部分仍占大头，这种“搭载型”的筹资模式既不利于长期护理保险制度的可持续发展，也加剧了很多地区医保基金的压力。

表 19 长护险试点城市筹资渠道

筹资渠道	试点城市
医保基金、个人缴费	承德、齐齐哈尔、重庆、盘锦、福州、湘潭、苏州
医保基金、个人缴费、福彩基金	石河子
医保基金、个人缴费、福彩基金、社会捐赠	天津
医保基金、个人缴费、财政补助	青岛、南通、宁波、安庆、荆门、广州、成都、北京石景山、晋城、开封、黔西南州、甘南州、汉中
医保基金、个人缴费、财政补助、福彩公益金	济南、淄博、枣庄、烟台、潍坊、济宁、威海、日照、临沂、聊城
医保基金、个人缴费、财政补助、社会捐赠	东营、德州、乌鲁木齐、呼和浩特
医保基金、个人缴费、财政补助、福彩公益金、社会捐赠	泰安、滨州、菏泽、昆明
医保基金、个人缴费、单位缴费、财政补助、社会资助资金	长春、吉林、通化、松原、梅河口、珲春
医保基金、个人缴费、财政补助、单位缴费、社会捐赠	上饶
单位缴费、个人缴费	南宁
单位缴费/财政补贴+个人缴费	上海

资料来源：深藏 blue 队整理

本文建议，未来应逐步实现长期护理保险费与医疗保险费同单独立征收（类

似与生育保险合并实施），同时停止医保基金和职工个人账户的划出，与医保基金完全脱钩，以保持与居民筹资结构的一致性（城乡居民医保账户已于五年前取消）。城乡居民长期护理保险的资金来源渠道保持不变，在 0.2%的筹资标准中，财政补助和个人缴费按同比例分担，即分别承担 0.1%，每年根据当地人均可支配收入的变化公布和调整具体缴费金额。例如，2023 年全国农村居民和城镇居民可支配收入分别为 2.2 万元和 5.2 万元，即该年度农村和城镇居民长期护理保险个人缴费金额（财政补助）分别为 22 元/人和 52 元/人。

4.4 经办模式：政府采购与保险机构委托管理

长期护理保险试点八年来，试点地区逐渐形成了社会力量参与程度依次提高的四种经办模式：以上海为代表的政府经办模式，以青岛为代表的专项委托模式，以成都为代表的部分委托模式和以南通为代表的全面委托模式。其中，绝大多数城市采取的是后两种模式，并对保险公司建立起监督考核办法、绩效评价机制、风险防范机制和相应的经办规程等。

表 20 长期护理保险经办模式的梳理

经办模式	特点	典型代表城市
政府经办	基本没有委托外部社会力量，所有经办事务均由医保部门亲力亲为	较少，只有上海、威海、济宁等
专项委托	将某 1～2 项经办事务委托给保险公司，例如：申请受理业务或失能评估业务。在此模式中，社会力量参与度最低，风险分担程度也最低，甚至基金不拨付至保险公司。	青岛
部分委托	承担的经办业务较多，除申请受理和失能评估，保险公司一般还承担费用审核、监督管理、稽核巡查、档案管理、信息化建设等，并承担一定的超支风险。	成都
全面委托	参与度最高的模式，指保险公司几乎参与经办业务全流程，还包括基金结算和政策制定等，且基金拨付至保险公司，保险公司承担超支风险。	南通

资料来源：深藏 blue 队整理

市场上保险机构也积极配合国家政策，结合公司自身战略定位设计经办推行

长护险的“打法特征”，形成了欣欣向荣的长护险市场格局，行业前端销售打法多样，但后端运营不足，尚未形成成熟模式。

表 21 长期护理保险竞业分析

竞业公司	战略定位	打法特征	能力储备情况
平安	公司 A 类战略项目，政府创新业务，探索保险向后端康养服务延伸。总部设立专属照护项目组	技术切入，深度参与各地政策制定；总分协同，总公司负责技术对接；主打“南通模式”和“经办技术”	市场上时间最长的长护经办经验；掌握国内领先的失能评估标准；自有长护经办系统，但无外部输出
国寿	民生保障新型项目，关注政治意义社会影响。总部无专属团队或部门	关系切入，省分公司为主要推动力；依托原有政保业务的关系粘性；以市级以上关系影响项目归属	市场上最多的项目承办数量；经办系统由万达信息代为建设；运营技术与远洋养老进行合作
人保财	民生保障新型项目，除关注政治意义外，还关注业务带来的短险增量。总部无专属团队或部门	整体打法与国寿类似	项目独家承办数量较多；经办系统由外部供应商提供
太保寿	政保合作重要项目，关注长护险带来的康养服务延伸价值和新增保险。总部设专属照护部门	技术切入，省分公司为主要推动力；主关键标准、既往经验、信息系统；辅以太保家园养老社区建设	国家级长护险项目经验最多；自有经办系统，且行业领先；养老护理头部企业提供技术支持
泰康养	集团医养核心战略之一，泰康养 G2C 大战略。总部设专属市场上最大的照护部门	技术切入人员派驻参与各地政策；广泛参与并尝试引导行业标准辅以泰康养老社区投资和运营经验	长护项目经验丰富；依托社区运营开发自有经办系统；养老社区提供项目运营管理技术
太平养	近期成为总公司重要政保业务，市场开拓动作较大。总部暂无专属团队或部门	系统切入+低价竞标策略；辅以梧桐之家养老社区建设	经办系统获上海金融奖行业领先

资料来源：深藏 blue 队整理

截至 2024 年 8 月底，在中国保险行业协会“人身险产品信息库”可查询到的在售商业长护险产品有 136 款。但现阶段，我国商业长护险存在产品形态简单、保费规模较小等问题。此外，大多数长护险产品，未能提供符合失能失智人群需求的护理服务，康复、护理类专业服务人才十分稀少，对失能、半失能老人提供专业护理的养老机构数量有限。

本文建议，商保公司需进一步整合资源，通过产业生态链的建设，从而使养老护理机构与商业长护险进行有效结合，实现闭环。一方面，此种资源整合有助于保险公司为投保老人提供更加优质的服务，赢得更多回头客；另一方面，对于养老机构来说，积极与保险企业进行合作，能将业务从 G 端向 B 端和 C 端转移，实现营收持续增长。

此外，业界人士普遍认为，重疾型长护险是未来商业长护险的发展趋势，“寿险转长护险”制度也能为公司提供积累市场资源的机会。据统计，目前在售的重疾型长期护理保险有 10 余款。中国人寿、人保寿险、太平人寿等寿险公司已在官网开设“人寿保险与长期护理保险责任转换”信息披露专栏，正式启动“寿险转长护险”业务及相关产品开发。

5 总结与展望

2016 年以来，各试点城市深入探索建立适应我国国情的长期护理保险制度，在许多政策领域进行了有益探索，取得初步成效，但也存在一些问题。下一步推进长期护理保险制度建设进程中，应在总结试点城市制度运行经验教训基础上，对其制度定位和模式选择进行审视，以期不断完善制度设计，提高其可持续性、公平性和规范性。

表 22 长期护理保险重要政策总结

时间	政策	内容
2016 年 6 月	人力资源和社会保障部办公厅印发《关于开展长期护理保险制度试点的指导意见》(人社厅发(2016)80 号)(以下简称“80 号文”)	长期护理保险制度试点工作在我国 35 个城市正式开始
2020 年 9 月	国家医保局和财政部发布《关于扩大长期护理保险制度试点的指导意见》(医保发(2020)37 号)(以下简称“37 号文”)	第二批 14 个城市进入试点范围，并对参保对象和保障范围、资金筹集、待遇支付、基金管理、服务管理和经办管理等进一步规范。

资料来源：深藏 blue 队整理

放眼世界各国，在税收筹资、嵌入医疗、健康或养老的社会保障制度，亦或是商业保险之外独立建立长护险制度的国家仅有六个，分别为荷兰、以色列、德国、卢森堡、日本、韩国。按 2015 年不变价格计算，这六个国家在建立长护险时人均 GDP 已达 3.4 万美元，相比之下 2016 年中国长护险试点时人均 GDP 仅为 8866 美元，老龄化率相对持平，说明我国“未富先老”情况凸显。

根据不同国家建立长期护理保险的时间节点，我国建立长期护理保险制度充分体现了“尽力而为、量力而行”的基本原则，是推进中国式现代化和实现共同富裕的重要举措；中国式现代化是人口规模巨大的现代化，也是实现全体人民共同富裕的现代化。

长期护理保险在建立之初采取便是“自下而上”“多点试错”的方法论，在经过若干年局部“摸着石头过河”的检验之后，中央政府最终及时作出决策，自上而下地在全国范围内统一制度。实践证明，这种独具中国特色的社会保障发展之路行之有效。历时八年的来自基层 49 个试点城市的“多点试错”为决策者提供了足够多的数据和思考，决策者应抓住时间机会窗口，尽快出台统一规范性政策。

参考文献

[1]肖文惠,宋燕,卞鹰.商业保险机构参与长期护理保险经办服务研究[J].卫生经济研究,2024,41(10):28-31.

[2]李裕吉.制度比较视角下城市长护险实施对比分析研究——以青岛市与安庆市对比为例[J].内蒙古财经大学学报,2024,22(05):65-69.

[3]郑秉文.长期护理保险的制度定位与模式选择[J].中国医疗保险,2024,(09):5-15.

[4]叶宇婷,许珂.长期护理保险对农村老年居民多维贫困的抑制效应分析[J].中国医疗保险,2024,(09):16-22.

[5]赵艳.银发经济背景下长护险高质量发展研究——以长护险试点城市呼和浩特市为例[J].中国医疗保险,2024,(09):38-43.

[6]戴卫东.中国特色长期护理保险建制的前瞻性思考[J].社会政策研究,2024,(03):38-47+132.

[7]张良文,魏翘楚,刘弘,马亦璇,赵博韬,李思成,陈思含.长期护理保险制度对我国老年人生理健康和心理健康状况的影响[J].医学与社会,2024,37(08):72-78.

[8]韩丽,王晓雨.长护险失能等级评估标准的适应性调整与优化研究[J].卫生经济研究,2024,41(08):16-19.

[9]牛伟硕.提升长护险居家护理服务质量的思考[J].中国保险,2024,(07):26-29.

[10]林岱衡,翁樱倍,谭清立,毛俊.长期护理保险需求与服务水平研究进展[J].老年医学研究,2024,5(03):48-52.

[11]薛惠元,张永高.共同富裕目标下长期护理保险的发展困境与优化路径——基于“路径-目标”理论的分析框架[J].学习与实践,2024,(06):117-129.

[12]刘子晗.长期护理保险筹资模式现状及国际经验[J].中国保险,2024,(05):11-15.

[13]杨一凡,蔡解语,王子怡,刘保华,王佳慧.长护险老龄受益者受益评价指标体系构建研究[J].卫生软科学,2024,38(05):77-81.

[14]刘馨雅,王鹏飞,井玉荣,王颖,谢洪彬.上海市长期护理保险参保老年人生活质量状况及影响因素分析[J].中国初级卫生保健,2024,38(05):23-27.

[15]陈小玮.长护险：为失能老人送去关爱[J].新西部,2024,(04):29-32.

[16]余孝娟.人口老龄化下我国商业长护险的营销策略[J].中国外资,2024,(08):41-43.

[17]陈飞,王若同.长期护理保险制度的共同富裕效应：基于照护决策与风险分担视角[J].世界经济,2024,(04):154-183.
[18]赵螓蛉,崔晓光,朱子文,江涌,龚波.长护险需求评估风险及预警模型初探[J].中国医疗保险,2024,(04):71-77.
[19]杜立金,周玲丽.终身寿险与长护险责任转换的精算比较[J].上海保险,2024,(04):35-38.
[20]关博文.寿险与长护险责任转换业务对长护险的影响分析[J].上海保险,2024,(04):48-52.
[21]曾梦宁.寿险转长护险试点一周年为失能群体提供更多选择[J].中国金融家,2024,(04):66-67.
[22]宋文佳.长期护理保险对家庭照料负担的影响研究[D].山东财经大学,2023.
[23]柯雅微.长期护理保险对我国失能老人家庭消费支出的影响研究[D].广东财经大学,2023.
[24]王英成.长期护理保险对老年人主观福利的影响研究[D].山东财经大学,2023.